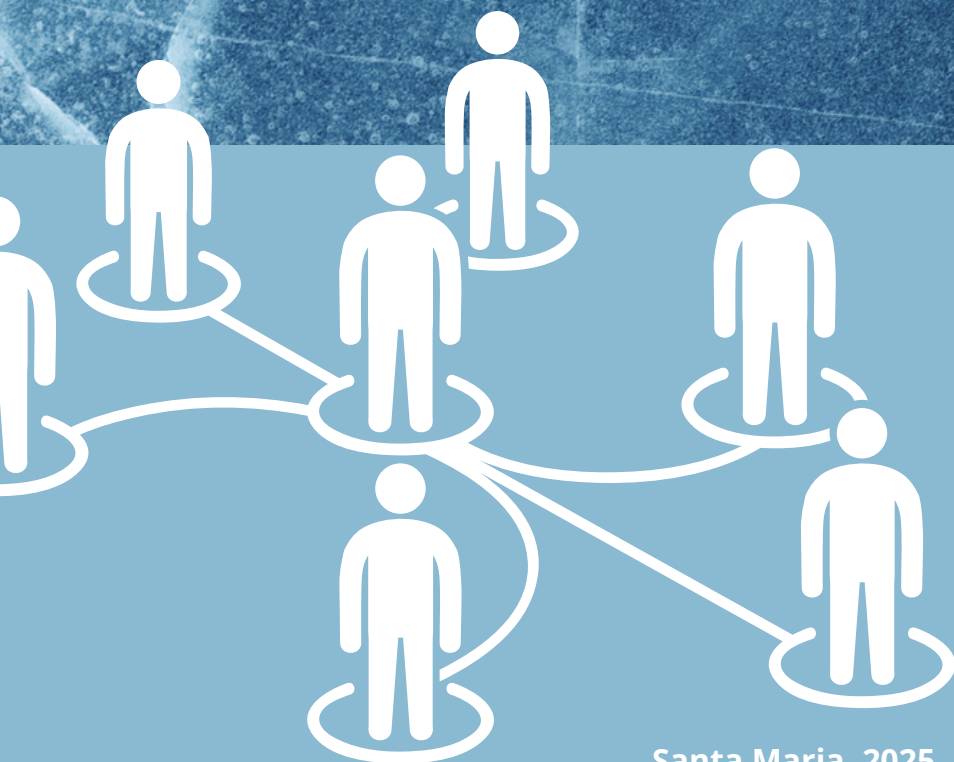


Rede de Atenção às Pessoas Portadoras de Condições Crônicas
Linha de Cuidado HA e DM
Política de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa
4ª Coordenadoria Regional de Saúde - 4ªCRS/SES/RS

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA



Santa Maria, 2025



**Rede Bem
Cuidar RS**



GOVERNO
DO ESTADO
**RIO
GRANDE
DO SUL**
SECRETARIA DA SAÚDE

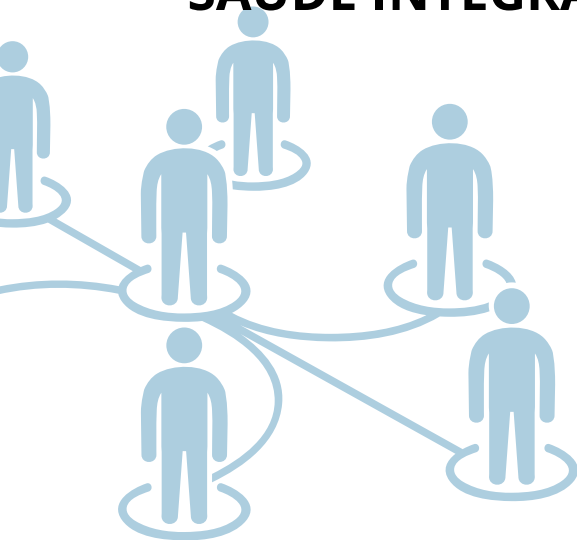


MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Rede de Atenção às Pessoas Portadoras de Condições Crônicas
Linha de Cuidado HA e DM
Política de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa
4ª Coordenadoria Regional de Saúde - 4ªCRS/SES/RS

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

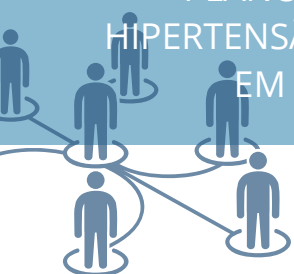


AUTORIA E ELABORAÇÃO:
Patrícia Mattos Almeida
Andriéli Müller Pagel
Caroline Ruviaro Dalmolin
Gisele Miollo

Coordenação Regional da Linha de Cuidado HA e DM
e Saúde da Pessoa Idosa - 4ªCRS:
Patrícia Mattos Almeida

Coordenadora Regional - 4ªCRS:
Fabrícia Ennes da Silva Costa

Coordenadora Regional Adjunta - 4ªCRS:
Carla Luciane Boniatti



APRESENTAÇÃO

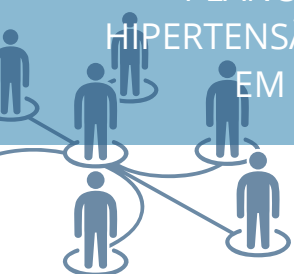
A Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS) tem a missão de “propor, promover e executar políticas de saúde com vistas a garantir o direito à saúde da população e melhorar a qualidade de vida”. Com vistas a alcançar tal premissa, a SES/RS organiza-se de forma hierarquizada, regionalizada e descentralizada, conforme prevê o Decreto 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde. Portanto, na perspectiva da regionalização da saúde, as Coordenadorias Regionais de Saúde, vistas como extensões da SES/RS nos territórios, são responsáveis pelo planejamento, acompanhamento e gerenciamento das ações e serviços de saúde, numa relação permanente de cooperação técnica, operacional e de diálogo com os municípios e com os prestadores de serviço, a fim de organizar os sistemas locais e regionais de saúde, segundo os princípios do SUS.

Sob este contexto, conhecer profundamente a população usuária dos serviços de saúde de uma região e/ou regiões, é o primeiro passo que nos possibilita estabelecer pontos de rompimento com a lógica do modelo hegemônico de atenção à saúde, baseado na oferta de consultas e procedimentos. A nós, profissionais da saúde, trabalhadores e trabalhadoras do SUS, interessa a construção de um modelo pautado em referenciais humanistas de Universalidade, Equidade e Integralidade. Com a intenção de superar os desafios e avançar na qualificação da atenção e da gestão em saúde, conforme estabelece o Ministério da Saúde para organização do trabalho em rede, é indispensável a existência de diretrizes baseadas em evidências, com foco na estruturação do cuidado para as pessoas e famílias usuárias, para que possam se movimentar, de forma efetiva e eficiente pela rede local e/ou regional, conforme suas necessidades e demandas de saúde.

Assim, este Plano Regional propõe o fortalecimento das linhas de cuidado da pessoa idosa e da pessoa com hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, no contexto das regiões de saúde Verdes Campos e Entre Rios do Estado do Rio Grande do Sul. A intenção é qualificar o cuidado prestado a essas subpopulações, tanto de forma coletiva quanto individual, disponibilizando conceitos, métodos de atendimento e fluxogramas que melhor se adequam ao panorama regional, que se destaca pela prevalência de pessoas idosas e de pessoas com hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus.

Patrícia Mattos Almeida

Coordenadora Regional das Linhas de Cuidado de HA e DM
e Saúde da Pessoa Idosa - 4ªCRS/SES/RS.



PREFÁCIO

Vivemos em uma época marcada pelo aumento significativo da expectativa de vida e pela transformação das estruturas sociais, que têm colocado em evidência a necessidade de uma atenção especial à saúde e ao bem-estar da população idosa. Este cenário demanda reflexão, planejamento e a implementação de ações eficazes que garantam a qualidade de vida, o respeito à dignidade e a promoção da autonomia das pessoas idosas. O PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA surge como uma ferramenta essencial nesse contexto, uma vez que permite uma abordagem de um olhar voltado ao coletivo social da comunidade idosa gaúcha, mas também um olhar atento ao sujeito uno, individualizado, levando em consideração não apenas as condições clínicas, mas também os aspectos emocionais, sociais e culturais de cada indivíduo, um sujeito holístico. Ele não é apenas um instrumento de organização dos serviços de saúde, mas também uma expressão concreta do compromisso com o cuidado centrado na pessoa idosa, fruto de um olhar atento ao processo sócio histórico de cada trabalhador e trabalhadora.

Neste Plano Regional para o cuidado, busca-se explorar os fundamentos, os desafios e as práticas relacionadas ao desenvolvimento e à aplicação de planos de cuidado para a população idosa. Ao longo das próximas páginas, você encontrará reflexões teóricas e exemplos práticos que ressaltam a importância de considerar as particularidades de cada idoso, incluindo suas preferências, histórias de vida e contextos familiares e sociais sob o olhar atento da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ªCRS) que visa estabelecer uma gestão de processos de Trabalho, Promoção e Educação em Saúde, Comunicação em Saúde e Ambiente e Participação Social, um marco na comunidade para identificar as necessidades de saúde locais.

Para tanto, a construção de um plano de cuidado eficaz requer a colaboração de diferentes áreas do conhecimento e a participação ativa da pessoa idosa e de sua família. Por isso, este trabalho também enfatiza a importância do trabalho em equipe multiprofissional, da comunicação empática e do uso de abordagens baseadas em evidências.

É igualmente essencial destacar a relevância de ações preventivas na promoção da saúde ao longo da vida. Doenças como a hipertensão arterial e o diabetes mellitus representam grandes desafios de saúde pública, especialmente para os trabalhadores que envelhecem. A conscientização sobre essas condições, combinada com a educação em saúde, pode prevenir complicações graves, reduzir os custos associados ao tratamento e garantir uma vida mais saudável e produtiva. Incorporar discussões sobre prevenção e manejo dessas doenças no ambiente de trabalho contribui para um envelhecimento mais ativo e saudável, promovendo também o bem-estar coletivo.

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

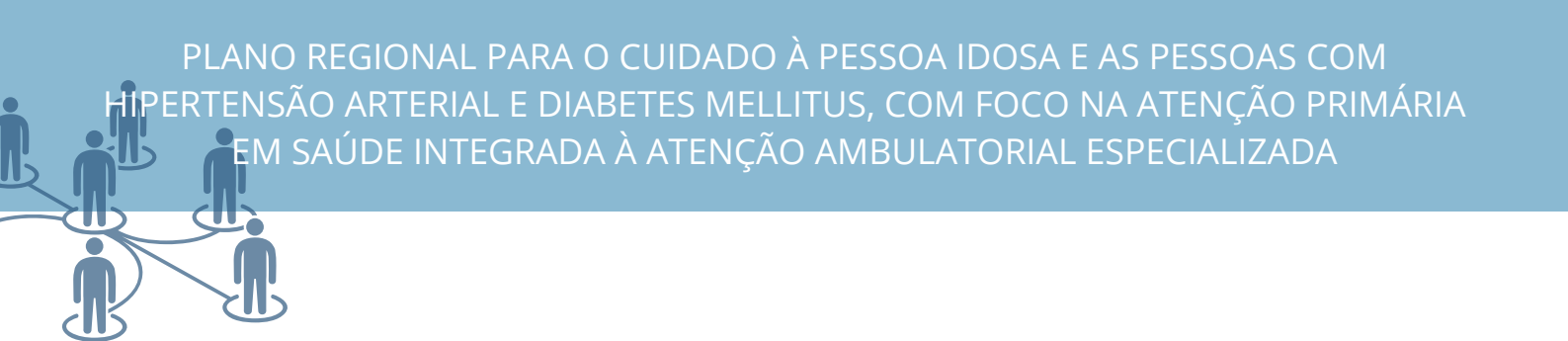
Convidamos você, caro leitor, a refletir sobre o impacto positivo que um plano de cuidado bem elaborado pode ter na vida das pessoas idosas, contribuindo para um envelhecimento digno, ativo e saudável. Que esta leitura seja uma fonte de inspiração e de conhecimento, incentivando a prática do cuidado com excelência e humanidade, pois o envelhecimento da população é uma realidade global que traz consigo novos desafios e oportunidades para os sistemas de saúde. Entre as condições crônicas mais prevalentes nesse contexto, reafirmamos, a hipertensão arterial e o diabetes mellitus destacam-se por sua alta incidência e impacto na qualidade de vida das pessoas idosas. Essas doenças exigem abordagens preventivas e terapêuticas integradas e coordenadas, especialmente na atenção primária à saúde, que é a porta de entrada do sistema de saúde e o espaço privilegiado para o cuidado contínuo e próximo da comunidade.

Este plano regional para o cuidado à pessoa idosa e às pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus reflete o compromisso da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ªCRS) de fortalecer a atenção primária em saúde como eixo estruturante de uma assistência eficaz e equitativa. Além disso, reconhece a importância da integração com a atenção ambulatorial especializada para garantir um manejo completo, desde a prevenção até o tratamento de complicações, promovendo a articulação de redes de cuidado capazes de responder às necessidades específicas desses grupos populacionais. Ao propor estratégias que priorizem a coordenação do cuidado, a educação em saúde e o acompanhamento contínuo, este plano visa não apenas melhorar os desfechos clínicos, mas também promover a autonomia, o bem-estar e a inclusão social das pessoas idosas e das pessoas com condições crônicas. Ele busca, assim, contribuir para a construção de um sistema de saúde mais humano, eficiente e preparado para enfrentar os desafios do envelhecimento populacional.

Na condição de coordenador do NEPEGSSS – Núcleo de Estudos Pesquisa e Extensão em Gerontologia, Serviço Social e Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, convidamos profissionais de saúde, gestores, acadêmicos e toda a comunidade a se engajarem na implementação e aprimoramento contínuo deste plano. Que ele seja um guia inspirador para transformar desafios em oportunidades e fortalecer a saúde como um direito fundamental e universal.

Dr. Jairo da Luz Oliveira

Professor Associado do Departamento de Serviço Social - UFSM



PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

POR QUE DEVEMOS PENSAR NO CUIDADO CENTRADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE INTEGRADA NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA?

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelece a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Ela possui a Saúde da Família como estratégia prioritária para expansão e consolidação. Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada e o centro articulador do acesso dos usuários ao SUS e às Redes de Atenção à saúde (RAS), sendo orientada pelos princípios de universalidade, equidade e integralidade (BRASIL, 2017).

Entende-se que a APS é um conjunto de ações direcionada a uma população em território definido, onde se realiza acompanhamento longitudinal e o cuidado à saúde dos indivíduos, famílias e coletivos. Ela envolve práticas de cuidado integrando a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento e reabilitação das pessoas, além de promover a redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, realizada por uma gestão qualificada e uma equipe multiprofissional (BRASIL, 2017).

Por outro lado, a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES) estabelece a organização da atenção especializada, com ênfase na sua articulação com APS. Entende-se a atenção especializada como um conjunto de conhecimentos, práticas assistenciais, ações e serviços de maior densidade tecnológica na produção do cuidado em saúde (BRASIL, 2023).

Entre os serviços que fazem parte da Atenção Especializada estão a rede de urgência e emergência, serviços de reabilitação, serviços de atenção domiciliar, rede hospitalar, serviços de atenção materno-infantil, serviços de transplante, serviços de atenção psicossocial, serviços de sangue e hemoderivados e a atenção ambulatorial especializada, incluindo os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (BRASIL, 2023).

Com foco no maior cuidado da população, a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde conta com um ambulatório pioneiro no Hospital Regional de Santa Maria. Ele surgiu em 2018 voltado a linha de cuidado para pacientes com hipertensão e diabetes, sendo que em 2022 foi implementada a linha de cuidado à pessoa idosa. Com isso, percebe-se que as pessoas atendidas pela Atenção Especializada apresentam a necessidade de cuidados diferenciados daqueles disponíveis na Atenção Primária, de modo que a Atenção Especializada deve desempenhar a integração e dar suporte à APS em um sistema de cuidados integrais (BRASIL, 2023; RIO GRANDE DO SUL, 2019).

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

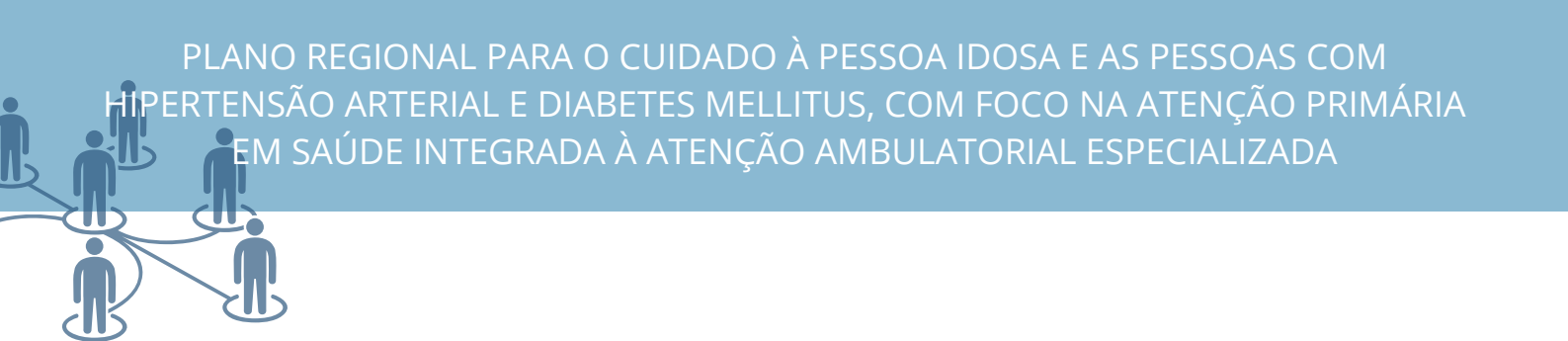
Pesquisas apontam que o acesso regular à APS reduz o fluxo de pessoas em serviços especializados e internações hospitalares, além de diminuir demandas em serviços de urgência e emergência e mortalidades, como resultado, a população possui uma melhor qualidade de vida e a atenção à saúde tem uma redução de custos gerais. Por isso, enfatiza-se a importância de uma melhoria da qualidade da atenção primária.

Ressalta-se que quando os cuidados ou tratamentos extrapolam a capacidade da resolução da APS, os usuários são referenciados para a atenção especializada, de forma que esse cuidado passa a ser compartilhado, integrado e colaborativo entre ambos os serviços. Sendo assim, a APS visa a promoção em saúde, prevenção de doenças e o autocuidado da comunidade, enquanto a atenção especializada atua quando as complicações com a saúde da pessoa está em seu estágio mais avançado, na atenção secundária ou, até mesmo na terciária.

Para estreitar a relação entre os níveis de atenção e facilitar a comunicação entre ambos a fim de compartilhar o cuidado e qualificar a assistência prestada ao usuário é necessário ter um plano de cuidado compartilhado. Nessa perspectiva, uma proposta inovadora é a atenção ambulatorial especializada integrada em redes coordenadas pela atenção primária à saúde ou o **MODELO DO PONTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA AMBULATORIAL (MODELO PASA)**.

O modelo PASA se sustenta em dois pilares fundamentais: a coordenação do cuidado entre a atenção ambulatorial especializada e a APS, e a construção da atenção ambulatorial especializada como um ponto de atenção secundária ambulatorial de uma Rede de Atenção à Saúde (RAS) coordenada pela APS. Sendo assim, a coordenação do cuidado é responsabilidade de generalistas e especialistas, sendo articulada e coordenada pela APS (MENDES, 2019).

Reitera-se que o cuidado centrado na Atenção Primária à Saúde (APS) integrado à Atenção Ambulatorial Especializada é essencial para garantir a eficácia, acessibilidade e resolutividade da assistência à saúde. A APS, ao estar mais próxima do usuário e compreender as especificidades do território e das famílias, será fundamental para a promoção do cuidado longitudinal, enquanto a Atenção Especializada irá complementar a APS com cuidados diferenciados, quando necessário, com seus serviços de maior densidade tecnológica. A integração entre esses dois pontos de atenção, por meio de modelos como o PASA, é crucial para assegurar uma atenção à saúde coordenada, contínua e centrada no usuário, promovendo melhores resultados para a população, reduzindo custos e otimizando os recursos disponíveis. A efetiva comunicação e o compartilhamento de responsabilidades entre os profissionais da APS e da Atenção Especializada irá contribuir para a humanização, integralidade e qualificação do sistema de saúde.



PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

SOBRE O AMBULATÓRIO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS PARA ADULTOS E PESSOAS IDOSAS DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

O AAE/HRSM opera segundo a lógica de ponto de atenção secundária ambulatorial (modelo PASA) e possui quatro funções essenciais: assistencial, supervisional, educacional e de pesquisa. Os(as) usuários(as) lá atendidos(as) são encaminhados pelas equipes da APS das Regiões de Saúde 1 e 2 do RS (Entre Rios e Verdes Campos) e passam por um ciclo de atenção contínua, isto é, uma sequência de atendimentos, e ao final, é elaborado um plano de cuidados a ser compartilhado com a APS. Após, preconiza-se o seu envio por e-mail para as coordenações municipais da Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente, duas linhas de cuidado estão em operação: a Linha de Cuidado de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus e a Linha de Cuidado à Saúde das Pessoas Idosas.

SOBRE O AMBULATÓRIO DE GERIATRIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - GERIHUSM

A Geriatria é a especialidade médica responsável pelos aspectos clínicos do envelhecimento e cuidados de saúde necessários para as pessoas idosas. É a área da medicina que cuida da saúde e doenças associadas ao envelhecimento, considerando aspectos físicos, mentais, funcionais e sociais nos cuidados agudos, crônicos, de reabilitação, preventivos e paliativos com o objetivo de otimizar a capacidade funcional e melhorar a qualidade de vida e autonomia da pessoa idosa. Segundo a OMS, a idade para um indivíduo ser considerado idoso é estabelecida de acordo com o nível sócio econômico de cada nação, sendo de 60 anos ou mais para países em desenvolvimento como o Brasil.

No HUSM, o GERIHUSM realiza abordagem de pessoas idosas em nível hospitalar, ambulatorial e domiciliar, a partir de acompanhamento clínico especializado, a partir do atendimento de consultoria (pacientes internados) ou interconsulta de Geriatria e encaminhamentos pela rede, encaminhados via regulação (pacientes ambulatoriais). O atendimento domiciliar é prestado no pós alta hospitalar imediato, visando transição de cuidados para paciente residentes em Santa Maria. Dessa forma, se propõe a atuar com as demais equipes na qualificação do cuidado prestado às pessoas idosas, com destaque para a avaliação de interações e risco e benefício de cada procedimento e/ou tratamento proposto e a identificação de modalidades de atendimento na rede de cuidado local, que possam auxiliar no processo de transição de cuidados, além da abordagem de fatores psico-sócio-econômicos comuns que afetam esse grupo etário, promovendo atuação conjunta com as equipes envolvidas na prestação do cuidado.

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM
HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

LISTA DE SIGLAS

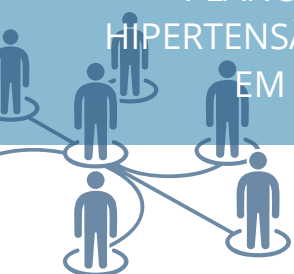
AAE	Atenção Ambulatorial Especializada
AMD	Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa
APS	Atenção Primária à Saúde
CIR	Comissão Intergestores Regional
CRS	Coordenadoria Regional de Saúde
DCNT	Doenças Crônicas Não Transmissíveis
DCV	Doença Cardiovascular
DM	Diabetes Mellitus
DM 1	Diabetes Mellitus tipo 1
DM 2	Diabetes Mellitus tipo 2
DMG	Diabetes Mellitus Gestacional
eAP	Equipe de Atenção Primária
EPS	Educação Permanente em Saúde
eSF	Equipe de Saúde da Família
HA	Hipertensão Arterial
HbA1c	Hemoglobina Glicada
HDL	Lipoproteína de Alta densidade
HF	Hipercolesterolemia Familiar
HRSM	Hospital Regional de Santa Maria
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM
HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

IMC	Índice de Massa Corporal
IVCF -20	Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional 20
LDL	Lipoproteína de Baixa Densidade
NEPEGSS	Núcleo de Estudos e Pesquisa e Extensão em Gerontologia, Serviço Social e Saúde
PA	Pressão Arterial
PAD	Pressão Arterial Diastólica
PAS	Pressão Arterial Sistólica
PASA	Ponto de Atenção Secundária Ambulatorial
PIAPS	Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde
PNAB	Política Nacional de Atenção Básica
PNAES	Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde
RAS	Redes de Atenção à saúde
RBC/RS	Rede Bem Cuidar RS
RCV	Risco Cardiovascular
SES	Secretária Estadual de Saúde
SISAB	Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica
SUS	Sistema Único de Saúde
SOP	Síndrome de Ovários Policísticos
TFG	Taxa de Filtração Glomerular
UBS	Unidade Básica de Saúde

SUMÁRIO

• INTRODUÇÃO	13
• PANORAMA REGIONAL	15
INDICADORES REGIONAIS	17
• OBJETIVOS	20
• OBJETIVOS REGIONAIS.....	20
OBJETIVOS GERAIS	20
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	21
LINHA DE CUIDADO DE HA E DM	22
CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO, SUAS PARTICULARIDADES, POPULAÇÃO E SUBPOPULAÇÕES	22
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E ESTRUTURAÇÃO DO CUIDADO OFERTADO AO USUÁRIO CONFORME AS NECESSIDADES DAS PESSOAS COM DIABETES E HIPERTENSÃO, DE ACORDO COM O ESTRATO DE RISCO, NA REDE LOCORREGIONAL DE SAÚDE	27
LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA	36
CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO, SUAS PARTICULARIDADES, POPULAÇÃO E SUBPOPULAÇÕES E AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA (AMD)	36
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CLÍNICO-FUNCIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO CUIDADO OFERTADO ÀS PESSOAS IDOSAS CONFORME SUAS NECESSIDADES, DE ACORDO COM O ESTRATO DE RISCO, NA REDE LOCORREGIONAL DE SAÚDE	50
• REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS	69



INTRODUÇÃO

O rápido processo de envelhecimento da população brasileira implica em urgente remodelamento dos sistemas sociais, em especial o da saúde, para atender suas reais necessidades. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) liberou, em final de 2022, os dados referentes às pessoas com 60 anos ou mais no país, demonstrando um acréscimo de 56%, quando comparados com os dados populacionais de 2010. Na década de 1980, o percentual de pessoas idosas no Brasil era de 6,1%, enquanto que, atualmente, esse grupo etário representa 15,8% da população total (MORAES, 2023).

Com relação a transição demográfica que ocorre no estado gaúcho, observa-se um decréscimo das taxas de fecundidade desde meados da década de 1950, em contrapartida, a expectativa de vida das pessoas idosas aumentou em 5,1 anos de vida entre 2000 e 2015, segundo os dados da Fundação Estadual de Estatística (FEE, 2023). Esse panorama indica que o número de pessoas com 60 anos ou mais ultrapassa o de crianças de 0 a 14 anos no Rio Grande do Sul, sendo registrado, mais precisamente, 115 pessoas idosas para cada 100 crianças em território estadual (IBGE, 2022).

Nesse cenário, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior proporção de pessoas idosas do país, cerca de 20,2% de sua população total, levando a um incremento de doenças crônicas em função de maior tempo de exposição aos fatores de risco (tabaco, inatividade física, uso abusivo do álcool e dietas não saudáveis). Assim, a estrutura e a organização do sistema de saúde traz a Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas e Política de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, como uma das redes temáticas a serem tratadas com prioridade pela gestão estadual (RIO GRANDE DO SUL, 2024).

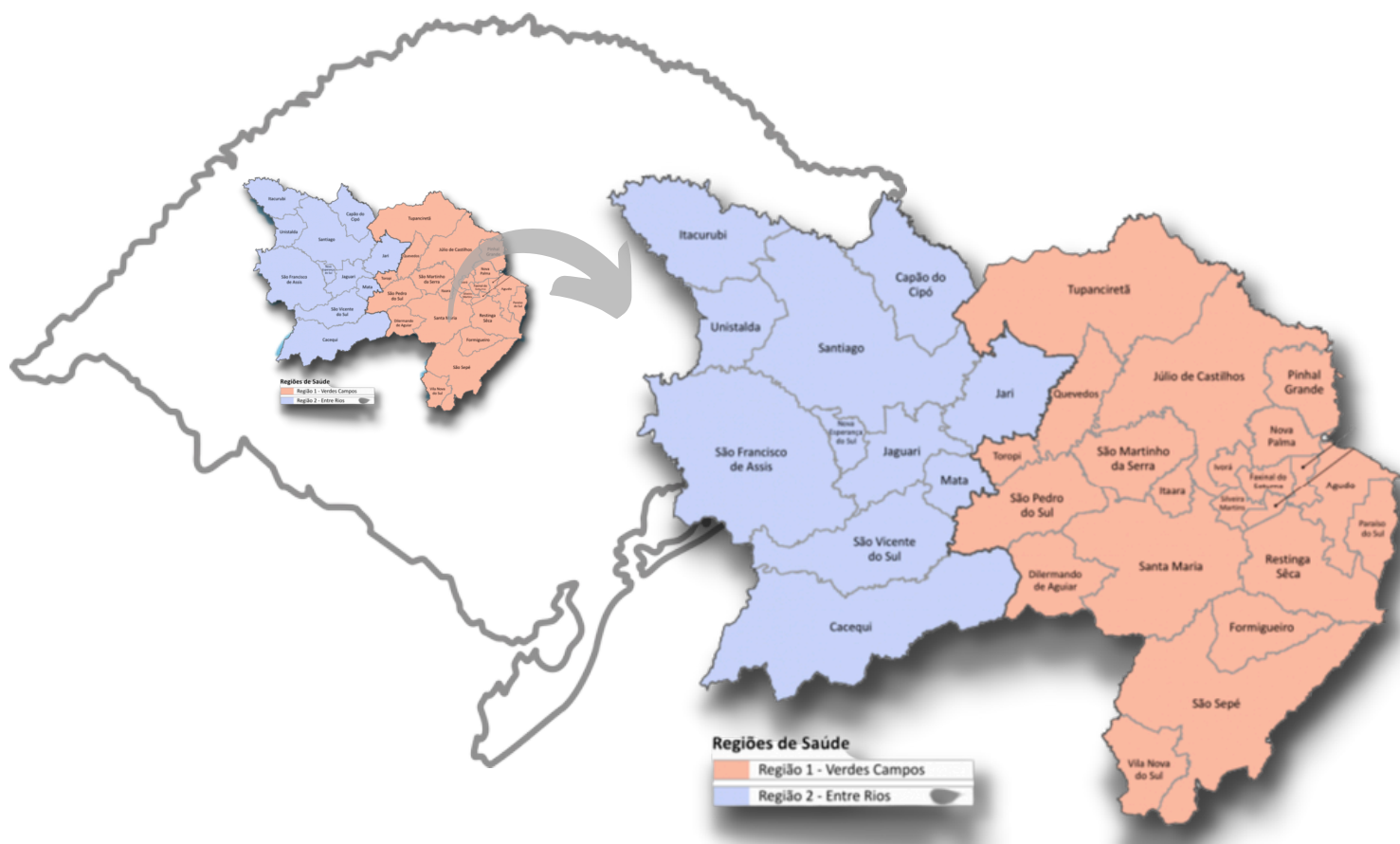
Contudo, no Estado vivemos além da transição demográfica, também a transição epidemiológica, sendo marcada pela predominância das condições crônicas de saúde, além de uma agenda ainda não superada de condições agudas, incluindo as endemias e mortes por causas externas. As mudanças profundas no estilo de vida das pessoas, o envelhecimento populacional e a transição nutricional revelam um panorama alarmante e complexo para a operacionalização das políticas de saúde nos territórios (MENDES, 2019).

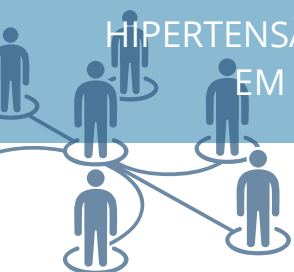
Observa-se, apenas na região sob responsabilidade da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ªCRS), 112.210 pessoas com diagnóstico de Hipertensão Arterial; 43.152 pessoas com diagnóstico de Diabetes Mellitus e prevalência de 74,63% de sobrepeso e obesidade nas pessoas com mais de 18 anos. Além disso, a região apresenta 122 mil pessoas com mais de 60 anos, o que equivale a 22,1% de sua população total.

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

O panorama exposto até aqui é um convite à reflexão profunda sobre as dinâmicas sociais e de trabalho, principalmente no que tange a organização macroeconômica do sistema de saúde que se expressa no dilema fundamental entre a segmentação e a universalização e, na existência de um modelo de atenção que ainda opera de forma fragmentada, sem comunicação entre os serviços e que, muitas vezes, acaba por não agregar valor para a vida das pessoas usuárias do sistema e suas famílias.

Indicando, de forma relevante, a existência concreta das transições demográfica, nutricional e epidemiológica que simbolizam a identificação do problema para a formulação de políticas públicas (RIO GRANDE DO SUL, 2023; SECCHI, 2023).



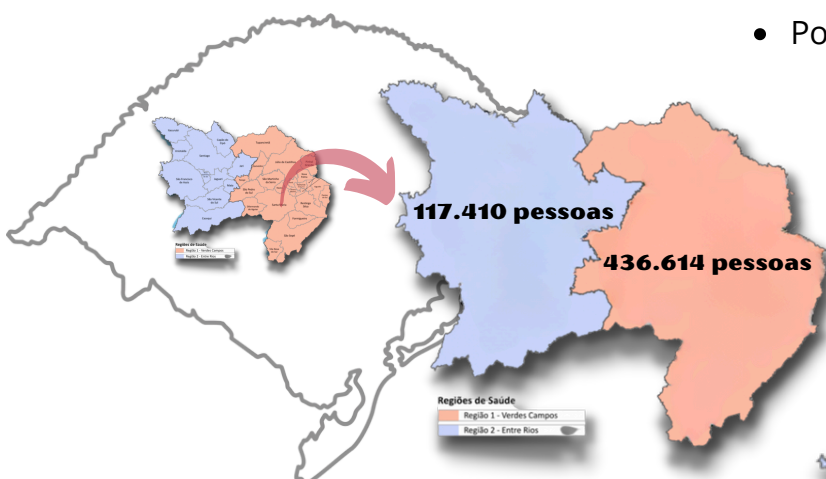


PANORAMA REGIONAL

INDICADORES REGIONAIS

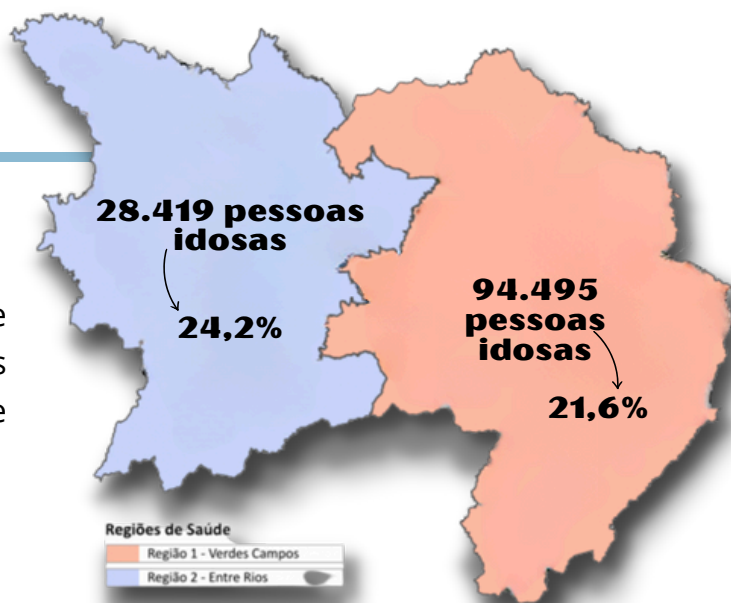
TERRITÓRIO E POPULAÇÃO:

- População total: 554.024 pessoas.



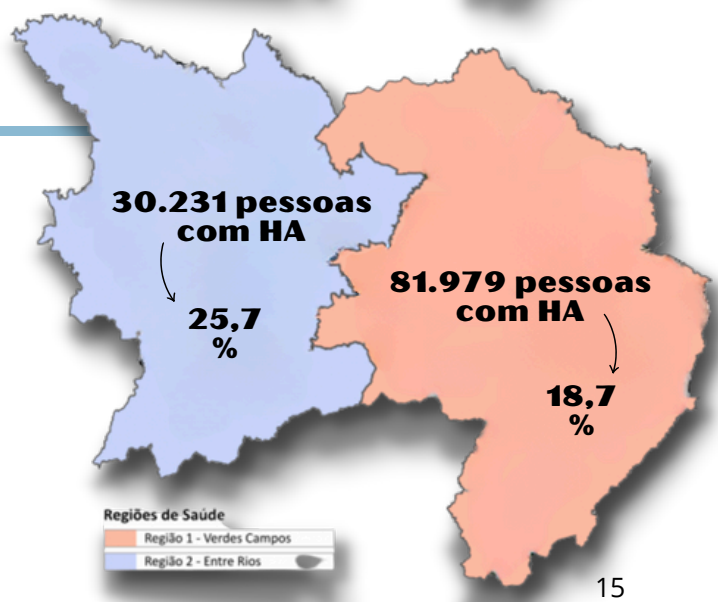
POPULAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS:

- População total: 122.914 pessoas com mais de 60 anos vivem nas regiões de saúde Verdes Campos e Entre Rios, equivalendo à 22,1% de sua população total.



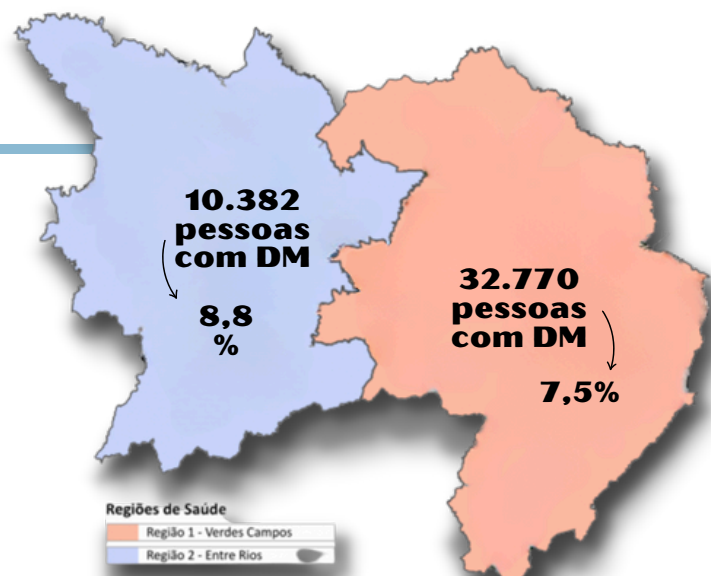
POPULAÇÃO DE PESSOAS COM HA:

- População total: 112.210 pessoas, maiores de 18 anos, que apresentam diagnóstico confirmado de Hipertensão Arterial, na região da 4ªCRS, equivalendo à 25,7% de sua população total.

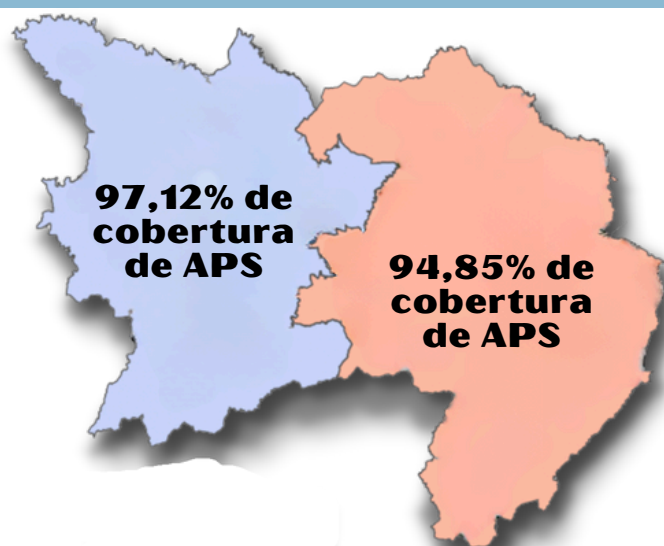


POPULAÇÃO DE PESSOAS COM DM:

- População total: 43.152 pessoas, maiores de 18 anos, que apresentam diagnóstico confirmado de Diabetes Mellitus, na região da 4ª CRS, equivalendo à 9,88% de sua população total.



COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE



Nº DE EQUIPES DE SAÚDE			
Região	eSF	eAP	Total
01	78	34	112
02	40	2	42

Apesar de alguns avanços na atenção à saúde das pessoas idosas, permanecem ainda alguns desafios a serem superados, como:

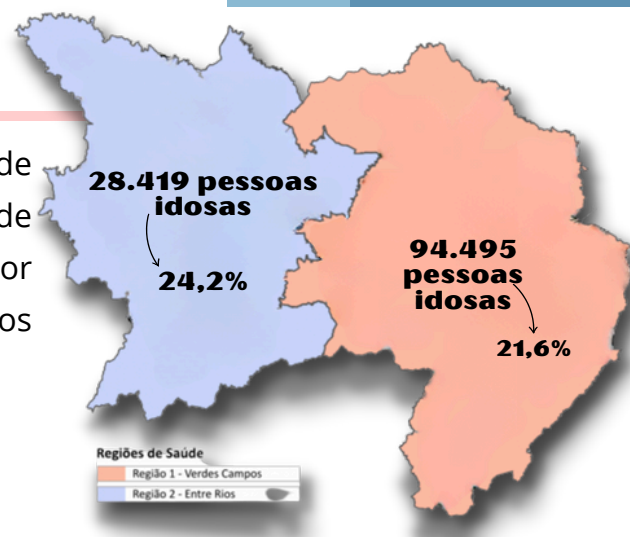
- Sistemas locais regionais frágeis no reconhecimento das necessidades e demandas das pessoas idosas: Ações tímidas; Ações pouco inovadoras de promoção da saúde e prevenção de agravos.
- Baixa resolutividade na APS: Peregrinação por especialistas; Risco de iatrogenias.
- Ausência de comprometimento, responsabilidade assistencial, organização da assistência, cuidado fragmentado, ações pontuais, sem continuidade no cuidado.
- Desarticulação com redes de apoio socioassistencial e demais políticas que tenham interface com a saúde em todos os níveis de atenção.

PANORAMA REGIONAL

INDICADORES REGIONAIS

REDE BEM CUIDAR/RS

A Rede Bem Cuidar/RS (RBC/RS) é um componente de incentivo estratégico que faz parte do Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (PIAPS). Tem por objetivo incentivar a melhoria e o fortalecimento dos serviços de APS oferecidos à população gaúcha.



O funcionamento da RBC/RS é composto por:

Adesão	Desenvolvimento	Monitoramento
Os municípios farão a adesão, com a indicação de uma equipe de Saúde da Família que integrará a RBC/RS, conforme os critérios estabelecidos.	A cada ciclo, a equipe RBC/RS desenvolverá um conjunto de ações previstas para qualificação dos processos de trabalho e de assistência em saúde ofertada à população. As ações estão organizadas a partir dos eixos estratégicos transversais.	A cada seis meses, a SES realizará o monitoramento das ações do ciclo em desenvolvimento e do atendimento aos critérios de adesão.

A RBC/RS desenvolve as ações baseadas em quatro eixos estratégicos transversais:

Gestão e Processo de Trabalho: diagnóstico do território, qualificar os processos de acolhimento, estratificação de risco e cuidado, monitorar e avaliar as ações.

Promoção e Educação em Saúde: promove ações considerando o conceito de aprendizagem significativa, considerando as experiências anteriores e vivências pessoais dos envolvidos.

Comunicação em Saúde e Ambiência: criar espaços agradáveis e acolhedores aos profissionais e usuários, potencializando a comunicação.

Participação Social: incentivar e fortalecer os espaços de organização e participação da comunidade para identificar as necessidades de saúde locais.

CERTIFICAÇÃO UBS AMIGA DA PESSOA IDOSA

A Certificação UBS Amiga da Pessoa Idosa é um projeto da SES/RS que visa qualificar os serviços e o cuidado em saúde à população idosa e seus familiares. A certificação das primeiras equipes com o selo UBS Amiga da Pessoa Idosa ocorreu por meio da adesão à RBC/RS. As UBS Amigas da Pessoa Idosa recebiam um Selo Bronze, Prata ou Ouro conforme o desempenho das ações implementadas, porém a partir do final de 2023 recebem apenas a certificação de UBS Amiga da Pessoa Idosa sem os selos. Ressalta-se que quem já possuía os selos, permanecem com os mesmos.

SELOS REDE BEM CUIDAR - UBS AMIGA DA PESSOA IDOSA					
Região	Ouro	Prata	Bronze	Adesão	Sem selo
1	14	2	1	5	-
2	4	1	2	1	3

Com a RBC/RS e a Certificação da Pessoa Idosa ocorrerá a realização de ações direcionadas à promoção do envelhecimento saudável ao instituir percursos nas redes de atenção e proteção às pessoas idosas, de modo a fortalecer o cuidado integral e integrado.

Conjunto de ações avaliadas a cada ciclo na RBC/RS e Certificação UBS Amiga da Pessoa Idosa:



Implementação da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa

Estratificação de risco

Plano de Assistência Domiciliar

Educação Permanente em Saúde

Reuniões de Equipe periódicas

Atividades coletivas com o público-alvo

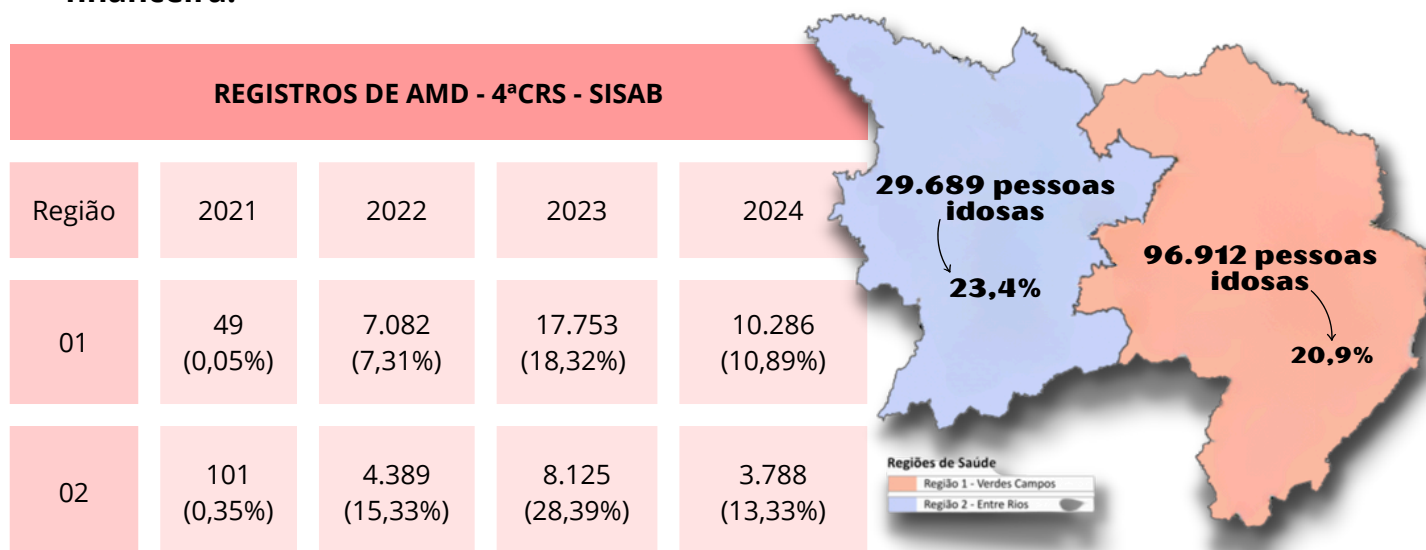
PANORAMA REGIONAL

INDICADORES REGIONAIS

INDICADOR BIPARTITE - NÚMERO 13

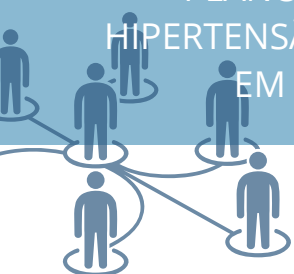
PERCENTUAL DE IDOSOS COM REGISTRO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA

- Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa é o principal instrumento de rastreio clínico-funcional da pessoa idosa;
- Promoção da **saúde integral da pessoa idosa** através de ações preventivas e/ou restaurativas;
- **Organização efetiva da rede** de atenção à saúde mediante o conhecimento do perfil das pessoas idosas;
- Gestão adequada do sistema de saúde, através da manutenção da **sustentabilidade financeira**.



Em relação ao período de 2021 a 2024, nota-se uma evolução significativa no percentual de idosos com registro do procedimento de avaliação multidimensional resultante de ações estratégicas desenvolvidas pela RBC/RS, que impulsionou a necessidade de conhecer o perfil da população idosa, nas regiões de saúde. Contudo, ressalta-se que apesar de avanços relevantes nesse cenário, o percentual de idosos ainda é insuficiente ao realizar o comparativo com o número de pessoas idosas existentes nos territórios.

Outrossim, foi possível perceber uma redução dos registros de AMD ao comparar o ano de 2023 a 2024. Tal fato pode ser decorrente das enchentes e inundações ocorridas por todo o RS durante o ano de 2024, as quais apresentaram impactos significativos na saúde pública e na infraestrutura dos serviços de saúde.



OBJETIVOS

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa tem como objetivo “recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde”, já a Política Estadual de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria SES Nº 444/2021), tem como objetivo principal “garantir a atenção integral à saúde das pessoas com 60 anos ou mais, promovendo a manutenção da capacidade funcional, da autonomia e independência, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável”.

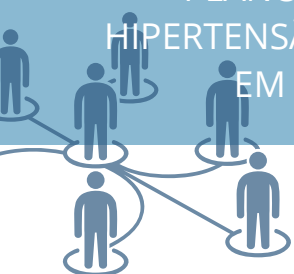
Com relação ao cuidado voltado para as pessoas com hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito, a Portaria Nº 483/2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde, tem como objetivos “realizar a atenção integral à saúde das pessoas com doenças crônicas, em todos os pontos de atenção, através da realização de ações e serviços de promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde; e fomentar a mudança no modelo de atenção à saúde, por meio da qualificação da atenção integral às pessoas com doenças crônicas e da ampliação das estratégias para promoção da saúde da população e para prevenção do desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações”.

OBJETIVOS REGIONAIS

OBJETIVOS GERAIS

LINHAS DE CUIDADO HA, DM E SAÚDE DA PESSOA IDOSA:

- Fortalecer as linhas de cuidado de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Saúde da Pessoa Idosa nas regiões de saúde Verdes Campos e Entre Rios, sob responsabilidade da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ªCRS/SES/RS).
- Qualificar a atenção à saúde das pessoas idosas, das pessoas com hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, com foco na Atenção Primária em Saúde integrada à Atenção Ambulatorial Especializada.



OBJETIVOS REGIONAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LINHA DE CUIDADO DE HA E DM:

- Conhecimento do território, suas particularidades, população e subpopulações;
- Estratificação de risco;
- Estruturação do cuidado ofertado ao usuário conforme as necessidades das pessoas com diabetes e hipertensão, de acordo com o estrato de risco, na rede locorregional de saúde.

LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA:

- Conhecimento do território, suas particularidades, população e subpopulações;
- Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (AMD);
- Estratificação de risco clínico-funcional;
- Estruturação do cuidado ofertado às pessoas idosas conforme suas necessidades, de acordo com o estrato de risco, na rede locorregional de saúde.

CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO, SUAS PARTICULARIDADES, POPULAÇÃO E SUBPOPULAÇÕES

Para qualificar a atenção à saúde das pessoas com HA e DM, primeiramente, deve-se ter o conhecimento da subpopulação de pessoas com essas condições crônicas, dentro da população geral no território em questão. Essa postura, frente ao usuário e ao sistema de saúde, permite uma modelagem integrada para as duas linhas de cuidado (HA e DM), visto a sua frequente associação e seus fatores causais serem comuns.

Devem ser identificadas as pessoas com fatores de risco para diabetes e hipertensão e dentre elas, devem ser diagnosticadas as pessoas que já tem a doença instalada, ou seja, já são pessoas com diabetes e/ou hipertensão, subdividindo esse grupo de acordo com a complexidade/risco, como condição simples (baixo/médio risco) e condição complexa (alto e muito alto risco) ou muito complexa.

Essa identificação permite o planejamento longitudinal em saúde, trabalhando dentro do princípio da equidade, previsto pela legislação do SUS, bem como orienta, de forma eficiente e efetiva, o itinerário terapêutico dos usuários dentro da rede de saúde local/regional. Na perspectiva do cuidado centrado nas pessoas e nas famílias, a identificação das subpopulações e o respectivo planejamento em saúde também orienta o compartilhamento do cuidado com a atenção ambulatorial especializada, sendo realizado de forma correta, agregando valor à vida das pessoas e suas famílias, sendo este o princípio e a diretriz mais importante de toda a rede de atenção à saúde.

CONCEITOS E CLASSIFICAÇÕES:

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica metabólica caracterizada pela elevação dos níveis de glicose no sangue, decorrente da produção insuficiente de insulina pelo pâncreas ou má absorção desse hormônio pelo corpo, ou em ambos os mecanismos. Existem 3 principais tipos de diabetes, classificados de acordo com sua etiopatogenia, a saber: Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1), Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) e Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) (RODACKI et al., 2022, INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2022; WHO, 2022)..

A DM1 é mais comum em crianças e adolescentes, mas adultos também podem ser diagnosticados. É caracterizada pela deficiência grave de insulina devido a destruição das células β , associada à autoimunidade. A apresentação clínica é abrupta, com propensão à cetose e cetoacidose, com necessidade de insulino terapia plena desde o diagnóstico ou após curto período (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2022).

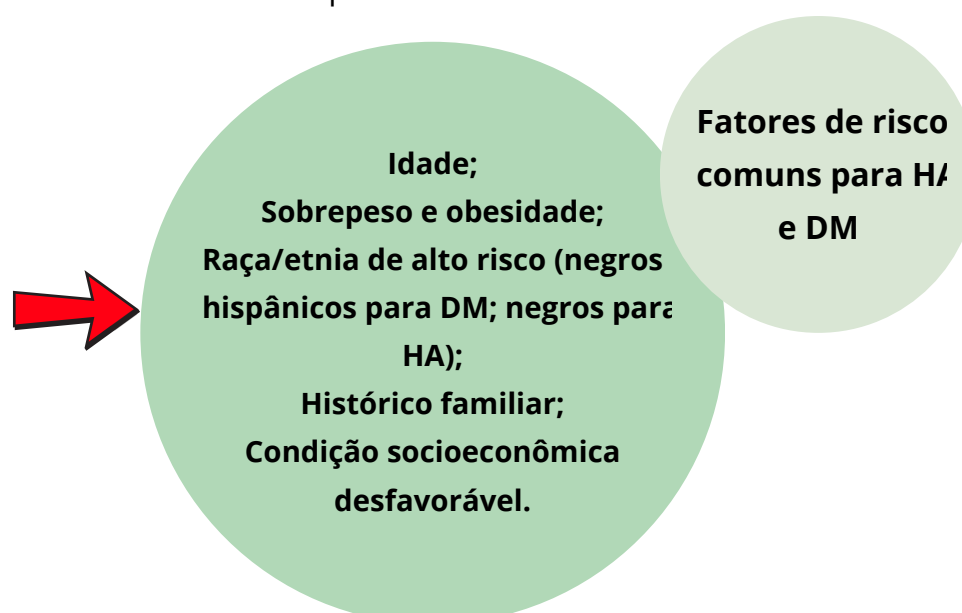
A DM2 é o tipo mais prevalente, e está frequentemente associada à obesidade e ao envelhecimento. Tem início insidioso e é caracterizada por resistência à insulina e deficiência parcial de secreção de insulina pelas células β pancreáticas, além de alterações na secreção de incretinas. Apresenta frequentemente características clínicas associadas à resistência à insulina, como acantose nigricans e hipertrigliceridemia (triglicerídeos elevados) (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2022).

A DMG é um tipo de diabetes que ocorre durante a gestação e usualmente desaparece após o parto. Pode ocorrer em qualquer estágio da gestação, mas é mais comum nos segundo e terceiro trimestre. Entre os principais fatores de risco para o DMG estão a obesidade, idade materna (≥ 35 anos) histórico familiar de DM e DMG em gestação anterior (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2022).

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2021) define a HA como uma doença crônica não transmissível (DCNT) definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento (não medicamentoso e/ou medicamentoso) superam os riscos. Trata-se de uma condição multifatorial, que depende de fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais, caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial (PA), ou seja, PA sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg, medida com a técnica correta, em pelo menos duas ocasiões diferentes, na ausência de medicação anti-hipertensiva.

FATORES DE RISCO:

Os fatores de risco para ambas DCNT são múltiplos, sendo alguns comuns e outros específicos, modificáveis e outros não modificáveis. Em ordem de impacto, estão os aspectos de ordem genética (histórico familiar de HA e DM), bem como os aspectos biológicos, psicológicos ou sociais associados estatisticamente a maiores probabilidades futuras de morbidade e/ou mortalidade.



PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

FATORES DE RISCO PARA HA E DM

Fatores de risco específicos para DM

Pré-diabetes;
Mulheres com diagnóstico prévio de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG);
História de doença cardiovascular;
HA;
HDL <35mg/dL e/ou triglicerídeos >250mg/dL;
Síndrome de ovários policísticos (SOP);
Uso crônico de medicamentos (corticóides);
Tabagismo.

Fatores de risco específicos para HA

Sexo masculino;
Uso excessivo de sal;
Uso excessivo de álcool.

Fonte: NT Saúde da Pessoa com DM e HAS - CONASS (2020).

FATORES DE RISCO MODIFICÁVEIS PARA HA E DM

SOBREPESO E OBESIDADE

Nas últimas décadas, a “transição nutricional”, que consiste em mudanças nos padrões de nutrição e de estado nutricional e modificações importantes dos padrões de atividade física, mostra-se como um dos fatores preponderantes para explicar o aumento da carga de DCNT, sendo também apontada como importante condição que predispõe à mortalidade.

DIETA INADEQUADA

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a dieta inadequada é o principal fator de risco para mortalidade precoce ao redor do mundo. O consumo elevado de ácido graxo saturado, gordura trans, carboidratos simples e alta ingestão de sal, acabam por causar dislipidemia, resistência insulínica, hipertensão e inflamação, levando a pessoa ao desenvolvimento de síndrome metabólica.

INGESTÃO DE ÁLCOOL E TABAGISMO

O álcool afeta a alimentação e a glicemia, prejudicando o controle do DM2, pois interfere na ação da insulina, aumentando o risco de hipoglicemia. Já o consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta a pressão arterial de forma consistente. Com relação ao tabagismo, evidências apontam o estabelecimento de vínculo causal entre tabagismo e DM2 e, alguns estudos indicam que a nicotina pode induzir disfunção e morte das células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Além disso, o tabagismo revela-se como um dos mais importantes fatores de risco reversíveis para a doença arterial coronariana.

INATIVIDADE FÍSICA E SEDENTARISMO

A prática de exercício físico é determinante na prevenção do DM2 e no tratamento de todas as formas de DM. Além de reduzir o risco cardiovascular, promover o bem-estar físico e mental, controle de peso corporal e adiposidade.

VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA

Adultos com menor nível de escolaridade (sem instrução ou com ensino fundamental incompleto) apresentam a maior prevalência de HA autorreferida. O DM e a obesidade aumentam em maior proporção na população com menor nível educacional e maior vulnerabilidade socioeconômica, tendo relação direta com seu estabelecimento.

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

FATORES DE RISCO MODIFICÁVEIS PARA HA E DM

PRÉ-DIABETES E PRÉ-HIPERTENSÃO

Na DM, alterações fisiopatológicas procedem em muitos anos o diagnóstico da doença. A condição na qual os valores glicêmicos estão acima dos valores de referência, mas ainda abaixo dos valores diagnósticos de DM, é denominada pré-diabetes. A resistência insulínica já está presente, porém, com o investimento em ações de promoção da saúde e prevenção de agravos é possível reverter o quadro. No entanto, na ausência de medidas de combate aos fatores de risco modificáveis, ela evolui frequentemente para a doença clinicamente manifesta e associa-se a risco aumentado de doença cardiovascular e demais complicações. As pessoas com pré-hipertensão tem maior probabilidade de se tornarem hipertensos e mais risco de desenvolverem complicações cardiovasculares, necessitando de acompanhamento periódico.

SARCOPENIA

A sarcopenia é definida como uma doença generalizada da musculatura esquelética, associada a desfechos adversos, como maior risco de fraturas, dependência física e mortalidade. Mostra-se três vezes mais comum em pessoas idosas com DM2, quando comparadas à população geral, manifestando-se em idade mais precoce e evolução rápida.

Fonte: NT Saúde da Pessoa com DM e HAS - CONASS (2020).

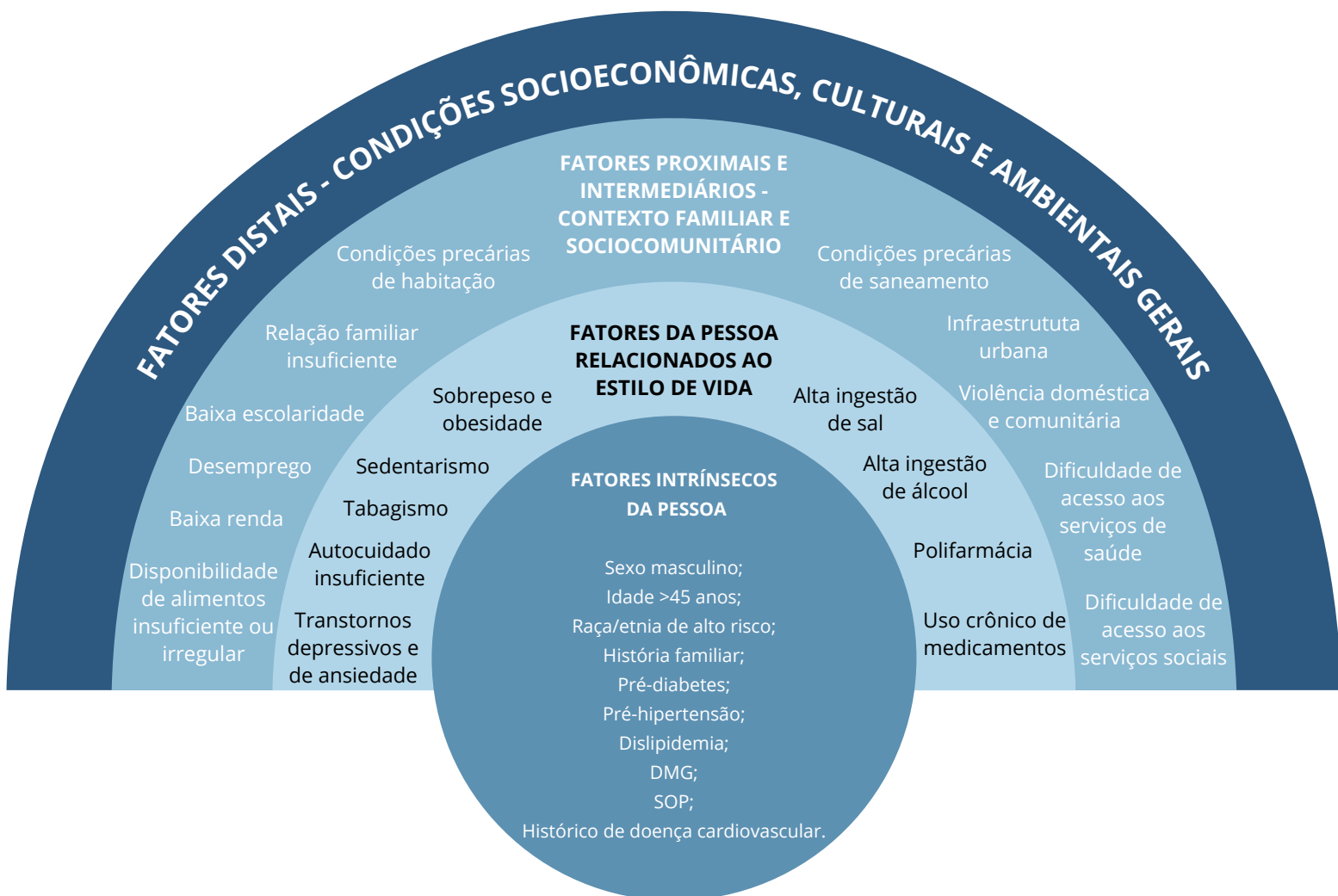
Observa-se também, a necessidade de mapear outros fatores determinantes da saúde, como sobrepeso e obesidade, que sofrem forte influência do ambiente e que, junto com redução de atividades físicas e aumento da ingestão calórica, representam os fatores determinantes ambientais mais fortes. A capacidade de autocuidado, o letramento em saúde, o suporte familiar e as condições socioeconômicas mostram-se como fatores importantes que caracterizam a situação do contexto de vida do usuário e, quando insuficientes, determinam de maneira negativa a saúde do indivíduo.

A maior ingestão de sal é consequência da mudança nos padrões de vida e comportamentos alimentares das pessoas, induzida pela urbanização. Esse fenômeno da urbanização cria um clima de urgência, pressa e multitarefismo, que se coloca como barreira para a prática de atividade física e facilita o consumo de alimentos ultraprocessados em maiores quantidades. A depressão e a ansiedade, bem como o estresse e a baixa qualidade do sono, não representam causas diretas de HA e DM, mas influenciam diretamente no estilo de vida e no comportamento dos sujeitos, principalmente no que tange à adesão terapêutica e a capacidade de autocuidado.

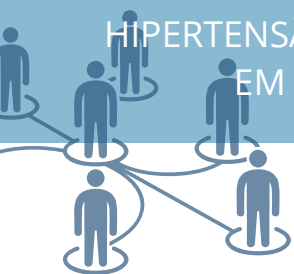
Nessa perspectiva, considerando a complexidade e diversidade dos fatores de riscos existentes e a necessidade de um cuidado longitudinal, integral, multiprofissional e constante para a promoção do autocuidado, acompanhamento e controle da HA e DM, ressalta-se a relevância do desenvolvimento de ações de educação permanente e educação em saúde.

Tais ações, respectivamente, irão promover a instrumentalização do profissional de saúde quanto a oferecer uma assistência com maior qualificação e segurança e sensibilizar o indivíduo com HA e DM quanto a emancipação do processo de cuidado e adesão ao tratamento para a transformação do estilo de vida e fatores de risco, contribuindo para a prevenção de agravos e complicações.

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA



Fonte: adaptado do modelo de determinação social da saúde de Dahlgren & Whitehead.



OBJETIVOS REGIONAIS

LINHA DE CUIDADO HA E DM

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E ESTRUTURAÇÃO DO CUIDADO OFERTADO AO USUÁRIO CONFORME AS NECESSIDADES DAS PESSOAS COM DIABETES E HIPERTENSÃO, DE ACORDO COM O ESTRATO DE RISCO, NA REDE LOCORREGIONAL DE SAÚDE.

O conhecimento profundo da população usuária de um serviço é elemento essencial para a organização da atenção à saúde. Isso é o que possibilita romper com a atenção baseada na oferta de consultas e procedimentos, características marcantes nos sistemas que não trabalham em rede.

A finalidade da estratificação de risco é classificar os usuários de determinado serviço, de acordo com a gravidade da sua condição crônica de saúde e sua funcionalidade. A partir dessa classificação, deve-se organizar, em conjunto com o usuário, uma série de atividades e metas a serem programadas de acordo com as suas necessidades individuais. Nessa perspectiva, no Rio Grande do Sul, as Notas Técnicas Estaduais subsidiam a atenção à saúde das pessoas com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus.

Vale destacar que o protocolo de estratificação de risco é um ferramenta útil e necessária que complementa a avaliação do usuário com HA e DM, ordenando o acompanhamento longitudinal da rede de saúde, mas não substitui a interação, o diálogo, a escuta e o acolhimento do cidadão nos serviços de saúde. A Atenção Ambulatorial Especializada, tratada neste documento, destina-se ao cuidado das pessoas que se encontram nos estratos de alto e muito alto risco e o idoso frágil. Porém, para os demais estratos destina-se dispositivos e ações como as de matriciamento, discussão de casos, interconsultas, encontros de educação permanente em saúde e supervisão clínica.

PORQUE DEVEMOS ESTRATIFICAR RISCO DOS USUÁRIOS?

A confirmação do diabetes baseia-se na detecção da hiperglicemia, já o pré-diabetes é uma condição de hiperglicemia intermediária, na qual os valores glicêmicos estão acima dos valores de referência, mas ainda abaixo dos valores para a confirmação do diagnóstico de diabetes (BRASIL, 2020).

A hipertensão arterial é uma doença crônica silenciosa, sem manifestações clínicas específicas até que os órgãos-alvo sejam afetados. A confirmação do diagnóstico se dá pela detecção de níveis pressóricos elevados, em duas ou mais aferições alternadas em dois ou mais dias, com pelo menos, uma semana de intervalo (BRASIL, 2020).

Contudo, mesmo com a confirmação diagnóstica, cada pessoa mostra-se como um universo a ser desvendado, com características e posturas individuais que ditarão, de forma consistente, o desfecho clínico de sua condição de saúde. Portanto, a estratificação de risco cumpre o objetivo de vigiar a evolução da hipertensão e do diabetes, identificando precocemente fatores de risco de agravamento e direcionando as intervenções preventivas e promocionais, de reabilitação ou palição para os indivíduos.

O outro objetivo da estratificação de risco é o conhecimento da complexidade clínica e funcional da pessoa e das subpopulações existentes no território, possibilitando uma atenção diferenciada, ofertando ao usuário de alto risco uma vigilância maior e mais intensa de cuidados em relação ao usuário de baixo risco. Além de oportunizar a padronização do cuidado de acordo com as necessidades dos usuários segundo o estrato identificado, definindo a intervenção mínima que deve ser garantida na rede de saúde.

Produções científicas realizadas em diferentes países ao redor do mundo, evidenciam que a estratificação dos riscos populacionais tem sido associada com melhor qualidade da atenção à saúde e maior eficiência no uso de recursos de saúde. **Contudo, mesmo com inúmeros benefícios, a estratificação de risco, quando desprovida de humanização e de um cuidado profissional qualificado, efetivo e eficiente, não se mostra capaz de agregar valor para a vida das pessoas usuárias dos serviços. Portanto, para o tratamento das DCNT, deve haver uma mudança na postura e no padrão comportamental do profissional da saúde diante do sujeito, que também sente e vive, através da formação de vínculos emancipatórios, com base em respeito mútuo, escuta qualificada, orientação e apoio para a realização do autocuidado.**

Destaca-se que os usuários, em todos os estratos de risco, devem ser acompanhados pelas equipes de atenção primária à saúde de sua referência, independente de necessitarem de compartilhamento do cuidado com a atenção ambulatorial especializada. Os municípios, gestores da APS, necessitam otimizar seus recursos para o tratamento destes usuários, lançando mão de estratégias já existentes, tais como:

- Academias de saúde;
- Ações de rastreamento de subpopulações;
- Ações estratégicas de promoção da saúde e prevenção de agravos destinadas às subpopulações rastreadas, como os grupos de pares, atividades educativas e compartilhamento do cuidado com a Atenção Ambulatorial Especializada, quando necessário.

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR (RCV) - Escore HEARTS

É recomendado que todas as pessoas com idade entre 40 e 74 anos sejam estratificadas quanto ao RCV (WHO, 2020). Entretanto, devido a relação existente entre o aumento da PA e o risco de doença cardiovascular (DCV), em ambos os sexos, todas as idades e grupos étnicos, é recomendado que, prioritariamente na APS todas as pessoas diagnósticas com HA sejam estratificadas quando ao RCV (BARROSO et al., 2021).

Existem diferentes escores disponíveis para a estratificação de risco cardiovascular. A SES recomenda a utilização do escore HEARTS (WHO, 2020), devido a este ser o escore recomendado pela iniciativa HEARTS, uma estratégia internacional que apresenta arcabouço técnico para auxiliar ministérios da saúde a fortalecer o manejo das DCV na atenção primária à saúde, a qual o Brasil aderiu no ano de 2021.

Além disso, o escore HEARTS possuiu calibração para características da população brasileira (composição racial, condições socioeconômicas e ambientais), considera fatores de risco amplamente disponíveis na APS, avalia desfechos relevantes (infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral fatais e não fatais) e é de fácil utilização, o que corrobora a orientação para sua escolha.

O escore HEARTS considera os seguintes critérios para estratificação de risco: diagnóstico de DM, gênero, tabagismo, idade, PAS (mmHg) e colesterol total (mg/dL), ou Índice de Massa Corporal (IMC), na ausência de informação laboratorial de colesterol (WHO, 2020). O resultado do escore avalia o risco de um evento cardiovascular em 10 anos.

Cabe ressaltar que, segundo as recomendações atuais (WHO, 2020), o cálculo do RCV é dispensável nas seguintes condições:

1. Alto risco cardiovascular

- Usuários com DM tipo II e idade > 40 anos
- Doença renal crônica $\geq 3B$

2. Muito alto risco cardiovascular

- Usuários com doença aterosclerótica estabelecida (doença coronariana, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório, insuficiência arterial periférica);
- Colesterol LDL ≥ 190 mg/dL ou hipercolesterolemia familiar (HF).

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

Quadro 1: Estratificação de risco de HA para adultos:

RISCO	CRITÉRIOS	PARÂMETROS DE PREVALÊNCIA
	COESTEROL TOTAL, GÊNERO, IDADE, TABAGISMO, PRESSÃO SISTÓLICA, PESO, ALTURA, E PRESENÇA DE DM.	23,9% da população adulta (IC95% 23,5%-24,4%).
BAIXO	Usuário com hipertensão arterial e Escore HEARTS <5%	40% DOS HIPERTENSOS
MÉDIO	Usuário com hipertensão arterial e Escore HEARTS entre 5 - 9%	35% DOS HIPERTENSOS
ALTO	Usuário com hipertensão arterial e Escore HEARTS entre 10 - 19%, e/ou com as situações abaixo: • Usuários com DM tipo II e idade > 40 anos • Doença renal crônica ≥3B	20% DOS HIPERTENSOS
MUITO ALTO	Usuário com hipertensão arterial ≥20% e/ou com as situações abaixo: • Usuários com doença aterosclerótica estabelecida (doença coronariana, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório, insuficiência arterial periférica); • Colesterol LDL ≥190 mg/dL ou hipercolesterolemia familiar (HF).	5% DOS HIPERTENSOS

Adaptado de WHO (2020) e NT Conjunta SES/RS Nº05/2023

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE USUÁRIOS COM DM TIPO 2

Segundo os critérios e os parâmetros para o planejamento e a programação de ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), existem quatro níveis para estratificação de risco com relação ao diabetes (baixo, médio, alto e muito alto risco) (BRASIL, 2015). Considerando o aumento da prevalência de DM2 em relação a idade e as atualizações nos critérios laboratoriais e clínicos para pessoas idosas (PITITTO et al., 2022), a estratificação de risco dessa NT foi subdividida entre pessoas adultas e idosas com DM2.

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

Quadro 2: Estratificação de risco de DM2 para adultos

RISCO	CRITÉRIOS	PARÂMETROS DE PREVALÊNCIA
	CONTROLE GLICÊMICO; HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1c); COMPLICAÇÕES E CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO	9,4% da população adulta (IC95% 9,9%-10,1%)
BAIXO	Usuário com diabetes diagnosticado, HbA1c <7% e TODAS as situações abaixo: - Controle pressórico adequado*; - Ausência de internações por complicações agudas** nos últimos 12 meses; - Ausência de complicações crônicas decorrentes do DM**; - Capacidade de autocuidado suficiente.	20% DOS DIABÉTICOS
MÉDIO	Usuário com diabetes diagnosticado, HbA1c <7% e TODAS as situações abaixo: - Controle pressórico adequado; - Ausência de internações por complicações agudas nos últimos 12 meses; - Ausência de complicações crônicas decorrentes do DM; - Capacidade de autocuidado insuficiente.	50% DOS DIABÉTICOS
	Usuário com diabetes diagnosticado, HbA1c entre ≥ 7% e 9% e todas as situações previstas no risco médio, com exceção da capacidade de autocuidado que deve ser suficiente.	
ALTO	Usuário com diabetes diagnosticado, HbA1c entre ≥ 7% e 9% e UMA DAS SITUAÇÕES ABAIXO, independente da capacidade de autocuidado: - Controle pressórico inadequado*; - Internação por complicações agudas nos últimos 12 meses; - Presença de complicações crônicas decorrentes do DM ou comorbidades graves (câncer, doença neurológica, doença cardiovascular, entre outras);	25% DOS DIABÉTICOS
	Usuário com diabetes diagnosticado, HbA1c entre > 9% e todas as situações previstas no risco alto, com exceção da capacidade de autocuidado que deve ser suficiente.	
MUITO ALTO	Usuário com diabetes diagnosticado, HbA1c > 9%, com capacidade de autocuidado insuficiente e UMA das situações abaixo: - Controle pressórico inadequado; - Internação por complicações agudas nos últimos 12 meses; - Presença de complicações crônicas decorrentes do DM ou comorbidades graves (câncer, doença neurológica, doença cardiovascular, entre outras).	5% DOS DIABÉTICOS

Nota: parâmetro de prevalência baseado na Pesquisa Nacional de 2019, considerando a população até 59 anos. Critérios laboratoriais especificados de acordo a Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (COBAS et al., 2022). *Controle pressórico adequado: PA ótima (120x80 mmHg) ou PA normal (121- 129x80-84 mmHg) (2021). **Complicações agudas consideradas: acidente vascular transitório ou não, infarto agudo do miocárdio, angina instável e doença arterial obstrutiva periférica com intervenção cirúrgica. ***Complicações crônicas decorrentes do DM: macrovasculares (doença arterial coronariana, doença cerebrovascular, doença vascular periférica) e microvasculares (retinopatia e nefropatia), neuropatia e pé diabético. Capacidade de autocuidado: Habilidade dos indivíduos, famílias e comunidades de manter e promover sua saúde, prevenir doenças e lidar com incapacidades com ou sem o apoio de um profissional de saúde (WHO, 2022)

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

Quadro 3: Estratificação de risco de DM2 para idosos

RISCO	CRITÉRIOS	PARÂMETROS DE PREVALÊNCIA
	CONTROLE GLICÊMICO; HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1c); COMPLICAÇÕES E CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO	19,9% (IC95% 16,3%-19,2%)
BAIXO	Usuário com diabetes diagnosticado, HbA1c <7,5% e TODAS as situações abaixo: - Controle pressórico adequado*; - Ausência de internações por complicações agudas** nos últimos 12 meses; - Ausência de complicações crônicas decorrentes do DM**; - Capacidade de autocuidado suficiente.	20% DOS DIABÉTICOS
MÉDIO	Usuário com diabetes diagnosticado, HbA1c <7,5% e TODAS as situações abaixo: - Controle pressórico adequado; - Ausência de internações por complicações agudas nos últimos 12 meses; - Ausência de complicações crônicas decorrentes do DM; - Capacidade de autocuidado insuficiente.	50% DOS DIABÉTICOS
ALTO	Usuário com diabetes diagnosticado, HbA1c entre ≥ 7,5% e 8,5% e UMA DAS SITUAÇÕES ABAIXO, independente da capacidade de autocuidado: - Controle pressórico inadequado****; - Histórico de Internações por complicações agudas nos últimos 12 meses; - Presença de complicações crônicas decorrentes do DM e/ou comorbidades crônicas e/ou comprometimento funcional leve/moderado e/ou comprometimento cognitivo moderado; - Capacidade de autocuidado insuficiente.	25% DOS DIABÉTICOS
MUITO ALTO	Usuário com diabetes diagnosticado, HbA1c entre ≥ 7,5% e 8,5% e UMA DAS SITUAÇÕES ABAIXO, independente da capacidade de autocuidado: - Controle pressórico inadequado; - Histórico de Internações por complicações agudas nos últimos 12 meses; - Presença de complicações crônicas decorrentes do DM e/ou comorbidades crônicas e/ou comprometimento funcional grave e/ou comprometimento cognitivo grave e/ou doença terminal; - Capacidade de autocuidado insuficiente.	5% DOS DIABÉTICOS

Nota: parâmetro de prevalência baseado na Pesquisa Nacional de 2019, considerando a população de 60 anos ou mais. Estratos de risco adaptados de acordo com os critérios laboratoriais e estados clínicos da pessoa idosa especificados de acordo a Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (PITITTO et al., 2022). *Controle pressórico adequado: PA ótima (120x80 mmHg) ou PA normal (121-129x80-84 mmHg) (2021). **Complicações agudas consideradas: acidente vascular transitório ou não, infarto agudo do miocárdio, angina instável e doença arterial obstrutiva periférica com intervenção cirúrgica. ***Complicações crônicas decorrentes do DM: macrovasculares (doença arterial coronariana, doença cerebrovascular, doença vascular periférica) e microvasculares (retinopatia e nefropatia), neuropatia e pé diabético. Capacidade de autocuidado: Habilidade dos indivíduos, famílias e comunidades de manter e promover sua saúde, prevenir doenças e lidar com incapacidades com ou sem o apoio de um profissional de saúde (WHO, 2022).

ACOMPANHAMENTO LONGITUDINAL

O diabetes e a hipertensão, em função da sua diversidade de fatores determinantes da situação de saúde e dos níveis de complexidade do quadro clínico funcional, requerem um acompanhamento longitudinal e organizado para o desenvolvimento de ações que beneficiem a vida do usuário em questão, fruto da criação de vínculo e da postura integrada e proativa da equipe de saúde.

Objetivo do acompanhamento longitudinal:



Estabilização clínica e fortalecimento da capacidade de autocuidado, devendo ser contemplados em todos os atendimentos, individuais e/ou em grupo.

PERIODICIDADE DAS CONSULTAS CLÍNICAS PARA DM E HA COM ESTABILIDADE CLÍNICA

ESTRATO DE RISCO	PERIODICIDADE (MESES)	CARACTERIZAÇÃO
BAIXO	6	Atendimento alternado médico e enfermeiro e equipe multiprofissional. Favorecer estratégias de atendimento em grupo para fortalecimento do autocuidado.
MÉDIO/INTERMEDIÁRIO	4	
ALTO E MUITO ALTO RISCO	2	Atendimentos compartilhados entre APS e AAE, ou seja, consultas bimensais em cada serviço da rede de saúde. Na APS os atendimentos devem ser alternados entre médico e enfermeiro, favorecendo o monitoramento do Plano de Cuidados Compartilhado e grupos voltados para o autocuidado.

- O número de atendimentos deve ser definido a partir da avaliação do usuário, considerando principalmente seu estrato de risco. Quanto maior a complexidade da situação, maiores a intensidade e a frequência das intervenções de vigilância e cuidado.
- A cada atendimento programado (consulta), deve-se realizar a reestratificação de risco e, se necessário, atualizar a agenda de acompanhamento do usuário na APS.
- A frequência e a intensidade dos atendimentos aumentam em situações de instabilidade clínica.
- Os atendimentos podem ser individuais (visando apoio à mudança de comportamento, estratificação de risco e tratamento), e em grupo (visando o apoio à mudanças nos hábitos de vida e autocuidado apoiado).
- Para os usuários de alto e muito alto risco, principalmente aqueles com instabilidade clínica ou complicações, devem ser acompanhados de forma compartilhada com a atenção especializada, focando no monitoramento do Plano de Cuidados Compartilhado e no autocuidado apoiado.

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

- O acompanhamento da pessoa idosa com HA e DM deve ser definido pela Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (uso do IVCF-20) e demais testes que a Equipe da APS e da AAE sintam necessidade.
- Os atendimentos em grupos devem ser estimulados, principalmente na APS, em função da importância para o desenvolvimento da capacidade de autocuidado dos usuários, tornando-se um espaço potente para escuta, acolhimento e trocas de vivências e experiências.
- Os Planos de Cuidado e de Autocuidado Apoiado devem ter/prever recomendações específicas para cada pessoa, levando em consideração, inclusive o seu contexto social e familiar.

CRITÉRIOS PARA COMPARTILHAMENTO DO CUIDADO COM A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA:

São critérios de encaminhamento para usuários portadores de DM, aqueles(as) classificados(as) como alto e muito alto risco, conforme Resolução NT Conjunta SES/RS 06/2023 e/ou:

- Usuárias(os) nos estratos de alto e muito alto risco em uso de insulina, ou usuários sem controle glicêmico adequado em uso de insulina em dose igual ou maior que 1 unidade/kg/dia e com boa adesão terapêutica;
- Doença renal crônica (taxa de filtração glomerular (TFG) < 30ml/mim/1,73 m² (estágio 4 e 5);
- Usuário diagnosticado com DM tipo I (uso de insulina como medicação principal antes dos 40 anos).

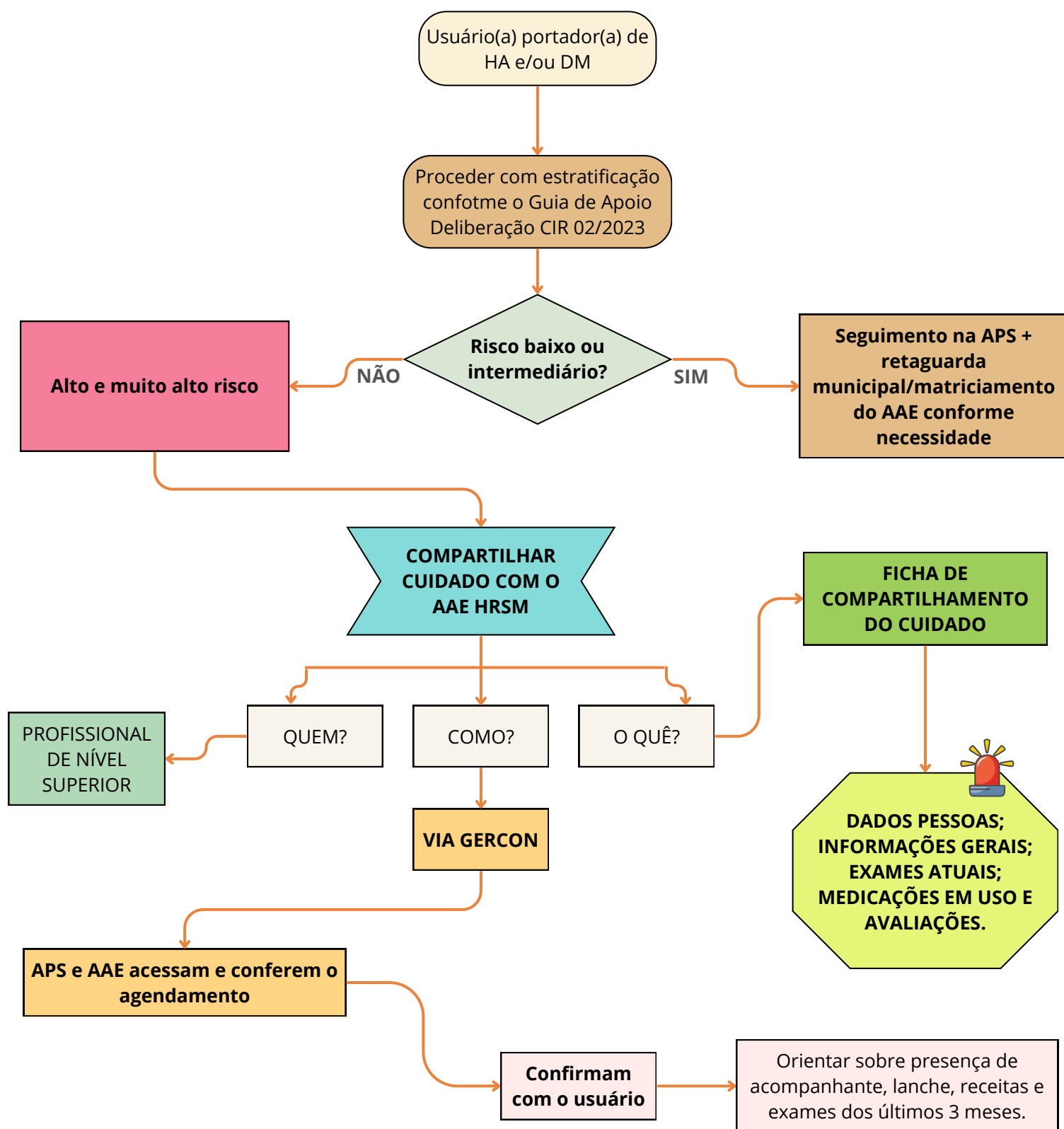
São critérios de encaminhamento para usuários(as) portadores(as) de HA, aqueles(as) classificados(as) como alto risco, conforme NT Conjunta SES/RS 05/2023 e/ou:

- Suspeita de hipertensão secundária; ou
- Hipertensão mal controlada (fora do alvo terapêutico) com no mínimo 3 medicações anti-hipertensivas.

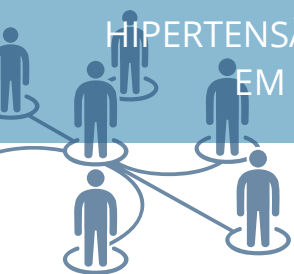
Outrossim, cabe destacar, que no contexto das regiões de saúde Verdes Campos e Entre Rios do Estado do Rio Grande do Sul, o Ambulatório de Condições Crônicas para Adultos e Pessoas Idosas do Hospital Regional de Santa Maria, atua no modelo de Ponto de Atenção Secundária Ambulatorial (PASA), o que prevê ações de matriciamento, supervisão clínica e encontros de educação permanente em saúde com todas as equipes de APS das referidas regiões.

Portanto, mesmo que o referido ambulatório esteja indicado à assistência direta de usuários de alto e muito alto risco, a assistência indireta ocorre aos demais estratos, conforme necessidade e solicitação das equipes da APS.

FLUXOGRAMA DE COMPARTILHAMENTO DO CUIDADO NA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS PARA AS REGIÕES DE SAÚDE VERDES CAMPOS E ENTRE RIOS



Elaboração: 4ª Coordenadoria Regional de saúde / SES-RS



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA

CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO, SUAS PARTICULARIDADES, POPULAÇÃO E SUBPOPULAÇÕES; E AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA (AMD)

O primeiro passo para a consolidação do trabalho em rede, pautado em um modelo humanista capaz de dispor de um olhar atento ao sujeito, sua construção histórica individualizada, que ultrapassa a condição clínica, mas que também reflete seus aspectos emocionais, sociais e culturais, é o conhecimento profundo da população do território. A nós, profissionais da saúde, cabe cuidar apenas de quem nós conhecemos! Não há outra alternativa! Portanto, para que esse conhecimento seja deveras produtivo, deve-se ter clareza sobre o que é a saúde da pessoa idosa, que não significa apenas a ausência de doenças.

O conceito de saúde da pessoa idosa está fortemente ancorado na sua **“capacidade individual de satisfação de suas necessidade biopsicossociais, independentemente da idade ou da presença de doenças”**. Essa capacidade funcional é resultado da combinação entre os fatores intrínsecos (capacidade física, mental e emocional do próprio indivíduo) e dos fatores extrínsecos (ambientais, nos quais o sujeito está inserido), o que leva a um processo de envelhecimento heterogêneo, ou seja, indivíduos da mesma idade tem processos de envelhecimento totalmente diferentes. Portanto, a fronteira entre os conceitos de saúde, doença, dependência e incapacidade deve estar bem definida (SBIBAE, 2019).

O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL:

Devemos compreender o processo de envelhecimento humano, para que possamos compreender as pessoas que cuidamos. O envelhecimento fisiológico, ou senescência, reduz a vitalidade do indivíduo, ou seja, sua defesa contra as agressões do meio interno e externo, gerando uma maior vulnerabilidade dessa população.

No entanto, essa diminuição da vitalidade, que ocorre no processo fisiológico de envelhecimento, não é suficiente para gerar incapacidades ou dependência funcional. Portanto, a saúde da pessoa idosa deve ser compreendida na sua multidimensionalidade de fatores determinantes, para que possamos, como profissionais do SUS, refletir e investir em ações/intervenções de saúde capazes de recuperar ou manter a autonomia e a independência da população idosa do nosso território/região.

Para destinar abordagens adequadas a população idosa nos diferentes pontos de atenção da RAS faz-se necessária a adoção de uma compreensão multidimensional para avaliar e identificar as necessidades e especificidades de cada pessoa idosa do ponto de vista clínico, psicossocial e funcional. Essa avaliação direciona as intervenções adequadas e o caminho a percorrer junto à RAS e/ou junto às redes intersetoriais – redes de assistência social, de proteção aos direitos básicos, de convivência, de lazer, esporte, cultura, educação, habitação, trabalho e renda etc., visando suprir lacunas e buscando a manutenção e/ou recuperação da independência e autonomia possíveis para melhor qualidade de vida no processo de envelhecimento (PARANÁ, 2018).

É importante ressaltar que a avaliação multidimensional supera a lógica curativista e o olhar estritamente biomédico/clínico sobre a população idosa. A avaliação multidimensional estrutura e organiza o cuidado às pessoas idosas, sendo elas (PARANÁ, 2018):

1. Dimensão Clínica:

Considera o histórico de saúde-doença por meio de uma anamnese ampliada e centrada no idoso, e o exame físico tradicional, buscando identificar a presença de agravos (quedas, hematomas, fraturas etc.), doenças crônicas e agudas, intervenções médicas já sofridas ao longo da vida, hábitos, antecedentes familiares e quantidade e tipos de medicamentos utilizados (PARANÁ, 2018).

2. Dimensão Psicossocial:

Enfatiza os aspectos relacionados à cognição, à memória, ao humor, aos comportamentos e à saúde mental de forma geral. Além disso, a avaliação psicossocial compreende o entendimento da dinâmica familiar, do suporte familiar e social, de questões econômicas, culturais, ambientais, étnico-raciais, de gênero (PARANÁ, 2018).

3. Dimensão Funcional:

Considera a manutenção da autonomia e da independência ao máximo possível, evitando ou retardando o declínio da capacidade funcional (PARANÁ, 2018).

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

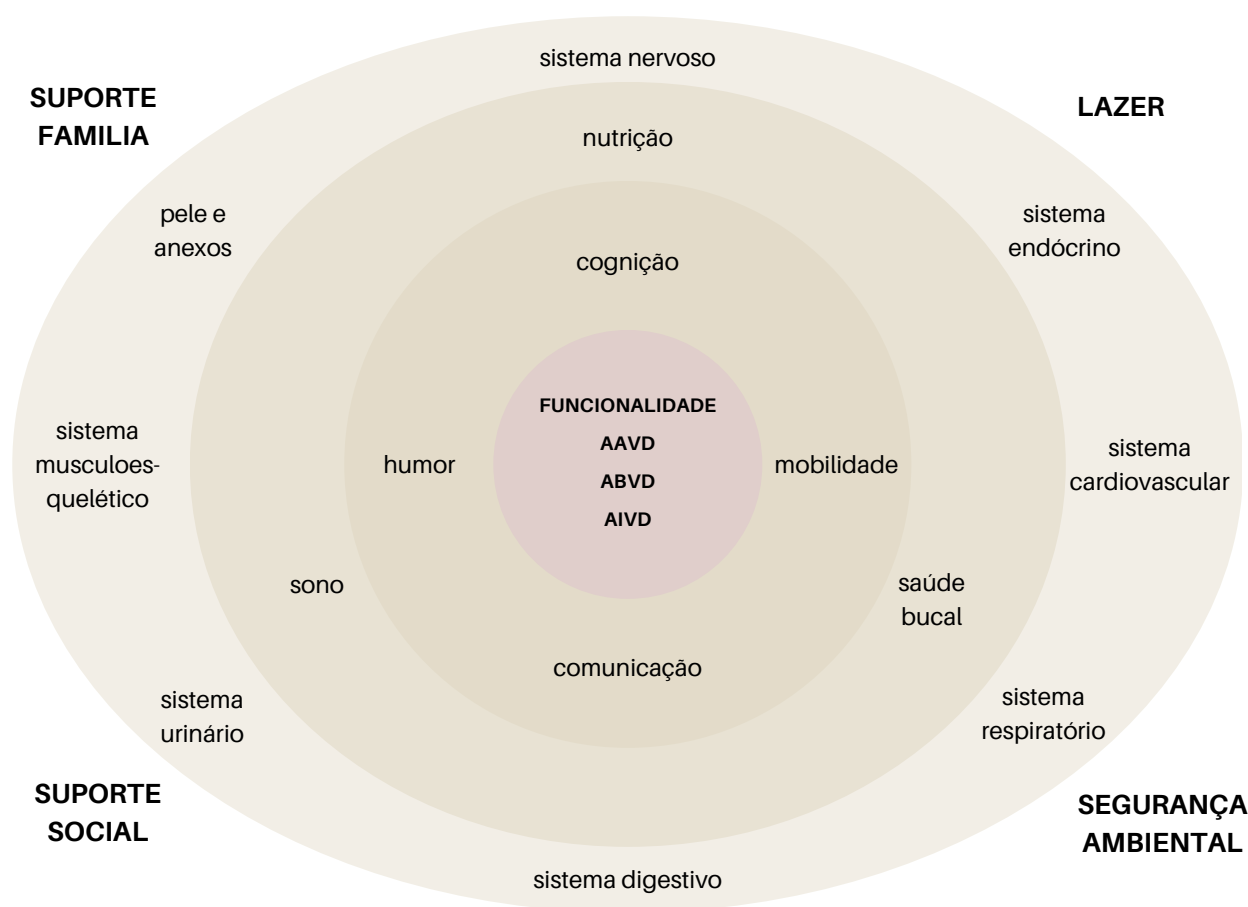


Figura 01 - Multidimensionalidade da saúde da pessoa idosa
Adaptado do Modelo de Edgar Nunes de Moraes.

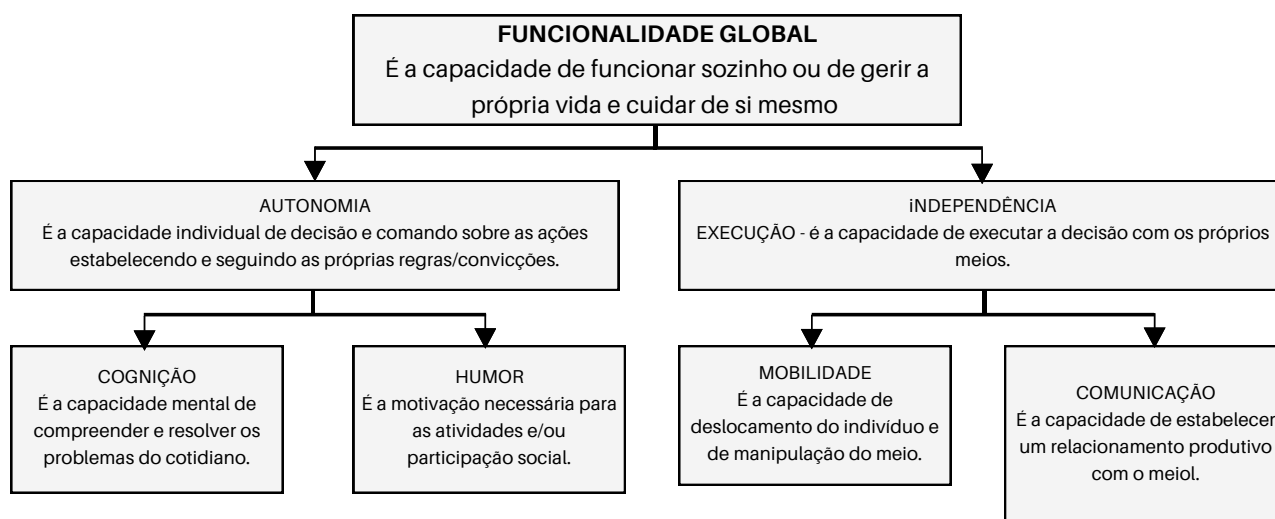
As necessidades biopsicossociais se referem àquelas tarefas fundamentais para a gestão da própria vida e do autocuidado, denominadas atividades de vida diária (AVD), que podem ser básicas (ABVD), instrumentais (AIVD) ou avançadas (AAVD).

ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (AVD)	
ATIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIÁRIA (ABVD)	Tarefas relacionadas ao autocuidado, como tomar banho sozinho, vestir-se sem ajuda, usar o banheiro, deitar-se e sair da cama sozinho (transferência), controle de esfíncter (urina e fezes) e alimentar-se sozinho.
ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA (AIVD)	Tarefas necessárias para o cuidado com o domicílio ou atividades domésticas, como o preparo das refeições, controle do dinheiro e do pagamento de contas, tomar os remédios na dose e horário correto, lavar e passar a roupa, uso do telefone, arrumar a casa e fazer pequenos trabalhos domésticos, fazer compras e sair de casa sozinho para lugares distantes.
ATIVIDADES AVANÇADAS DA VIDA DIÁRIA (AAVD)	Atividades mais complexas, relacionadas à integração social, como as atividades produtivas, recreativas e de participação social.

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

Essa capacidade funcional da pessoa idosa para realização das AVDs está relacionada à sua autonomia e à sua independência – conceitos complementares, mas associados a domínios funcionais diferentes. A autonomia depende da cognição e do humor/comportamento, enquanto a independência depende da mobilidade e da comunicação.

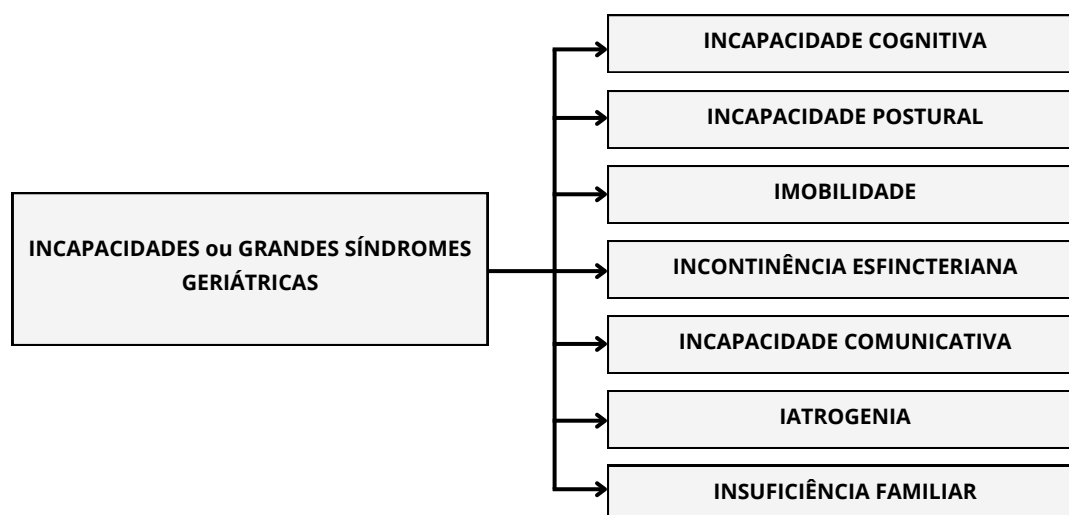
Figura 02 - Esquema da funcionalidade global



O comprometimento desses domínios funcionais impede o sujeito de gerir sua vida e/ou cuidar de si mesmo, gerando as dependências funcionais, também conhecidas como **incapacidades**. Essas incapacidades são condições crônicas na saúde da pessoa idosa, e por isso requerem cuidados de longa duração e uma gestão diferenciada por parte dos profissionais de saúde e familiares.

Uma estruturação inadequada do cuidado para a pessoa idosa com dependência funcional pode resultar em maior risco de iatrogenia, assim como uma família que não está preparada para prover os cuidados necessários (insuficiência familiar), pode agravar, ainda mais, a situação da pessoa idosa.

Figura 03 - Incapacidades funcionais da pessoa idosa



PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

A pessoa idosa que apresenta uma ou mais das incapacidades, acima descritas, é considerada uma pessoa idosa frágil. Para a estruturação adequada do cuidado em saúde, o termo “Fragilidade Multidimensional” é utilizado para indicar uma situação do idoso em que há uma redução da capacidade funcional e/ou da capacidade de adaptação às agressões biopsicossociais e, conseqüentemente, ocorre uma maior vulnerabilidade ao declínio funcional, à institucionalização e ao óbito.

Neste conceito, as condições de saúde associadas a desfechos adversos podem ser agrupadas em dois componentes, **clínico-funcional e sociofamiliar**, resgatando o conceito de saúde como o máximo bem-estar biopsicossocial e não simplesmente como a ausência de doenças. O componente clínico-funcional da Fragilidade Multidimensional tem como premissa a capacidade do idoso de ser independente nas AVD. A fragilidade indica, justamente, o declínio dessa capacidade funcional, podendo este ser iminente ou estabelecido (MORAES, 2023).

Figura 04 - Modelo multidimensional da funcionalidade global da pessoa idosa

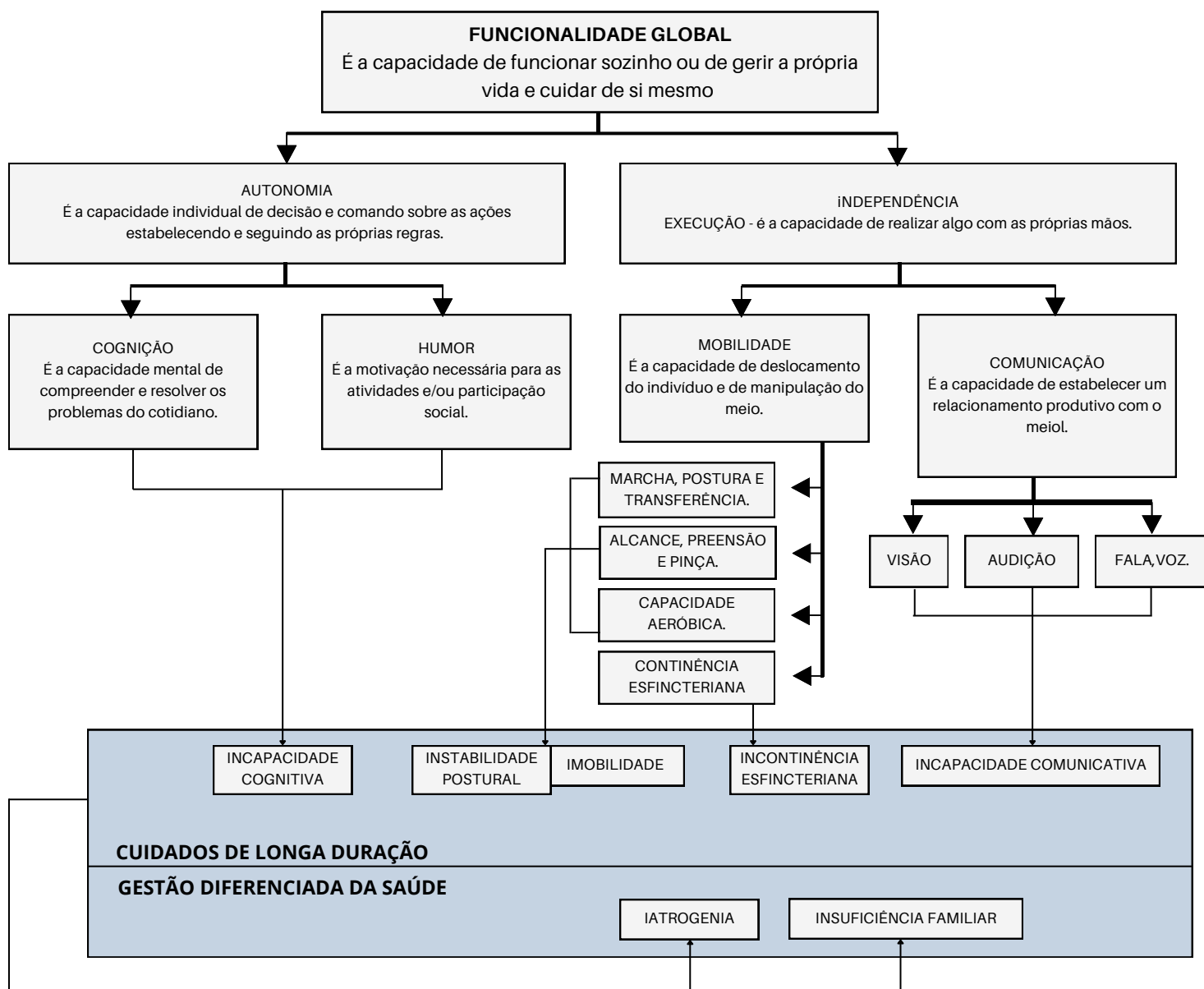


Figura 02 - Adaptado do Modelo de Edgar Nunes de Moraes.

CONHECENDO A PESSOA E A POPULAÇÃO IDOSA:

No Brasil, o Estatuto do Idoso define como pessoa idosa todo indivíduo com 60 anos ou mais. Portanto, vale resgatar a compreensão da heterogeneidade que acompanha o processo de envelhecimento, visto que o território, a constituição familiar, o ambiente e a comunidade na qual o idoso vive sua historicidade e sua individualidade é tanto mais heterogêneo, quanto maior for a sua idade.

Assim, o conhecimento da população idosa começa pela identificação desses usuários na população geral residente por meio do cadastramento individual e familiar. O profissional/equipe de saúde responsável pelo cuidado do usuário em questão, deve buscar dados do contexto de vida da pessoa idosa, os fatores multidimensionais que determinam sua capacidade de realizar as Atividades da Vida Diária (AVD), considerando os recursos disponíveis, fatores de proteção, fatores de risco relacionados a relações familiares e comunitárias, ambiente domiciliar e peridomiciliar, atividades produtivas, recreativas e de participação social.

Do ponto de vista sociofamiliar, os principais fatores de risco são:

- Morar sozinha;
- Residir em ILPI;
- Ausência de companheiro ou cônjuge;
- Viuvez recente;
- Ausência de familiares, amigos ou cuidadores com disponibilidade para atender a pessoa idosa, principalmente o dependente de cuidados;
- Ausência de visitas de familiares e amigos com regularidade;
- Ser responsável pelo cuidado de pessoas dependentes em sua casa;
- Analfabetismo;
- Ser dependente do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e/ou não ter acesso a renda própria capaz de garantir a própria subsistência;
- Não possuir moradia própria ou ter moradia própria em condições precárias de organização e higiene;
- Não participar de alguma atividade de socialização extradomiciliar;
- Ter indícios ou ocorrências de violência doméstica.

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE GLOBAL DA PESSOA IDOSA

A Coordenação Regional da Política de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa da 4ªCRS/SES/RS indica a utilização do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional-20 (IVCF-20) como instrumento para avaliação da funcionalidade global da pessoa idosa.

O Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-20 é referência em nível nacional para estratificação de risco de pessoas idosas, sendo desenvolvido e validado no Brasil, a partir do Vulnerable Elders Survey-13 (VES-13) e de outros instrumentos de triagem rápida amplamente citados na literatura. É um instrumento para identificação rápida da fragilidade no idoso. Em 2019, foi reconhecido como sendo um dos quatro melhores instrumentos do mundo capazes de reconhecer a fragilidade na população idosa (RIO GRANDE DO SUL, 2022; MORAES, 2023).

O IVCF-20 é um instrumento de fácil compreensão e aplicação, **levando de 5 a 10 minutos para ser finalizado** e avalia oito dimensões consideradas preditoras de declínio funcional e/óbito em idosos: idade, autopercepção da saúde, atividades da vida diária, cognição, humor/comportamento, mobilidade (alcance, preensão e pinça; capacidade aeróbica/muscular; marcha e continência esfincteriana), comunicação (visão e audição) e presença de comorbidades múltiplas, representadas por polipatologia, polifarmácia e/ou internação recente (RIO GRANDE DO SUL, 2022; MORAES, 2023).

- Pode ser aplicado por qualquer profissional da equipe (enfermeiro, médico, dentista, ACS, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social, dentista, psicólogo, farmacêutico entre outros), desde que devidamente capacitados e autorizados por diretrizes municipais, quando necessário;
- Pode ser realizado durante o atendimento individual, visita domiciliar, atendimento familiar e em todas as oportunidades de contato com a equipe assistencial (vacinação, renovação de receita, dispensação de medicamentos, consultas por situações agudas, atividades educacionais, grupos de convivência) **ou em mutirões de avaliação;**
- A metodologia propõe uma pontuação que possibilita correlacionar o risco de vulnerabilidade clínico-funcional e o declínio funcional da pessoa idosa.

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLÍNICO-FUNCONAL-20

Responda as perguntas abaixo com a ajuda de familiares ou acompanhantes. Marque a opção mais apropriada para a sua condição de saúde atual. Nos idosos com incapacidade para responder, utilizar as respostas do cuidador.

			PONTUAÇÃO
IDADE	1. Qual é a sua idade?	☐ 60 a 74 anos ⁰ ☐ 75 a 84 anos ¹ ☐ ≥ 85 anos ³	
AUTO-PERCEPÇÃO DE SAÚDE	2. Em geral, comparado com outras pessoas da sua idade, você diria que a sua saúde é:	☐ Excelente, muito boa ou boa ⁰ ☐ Regular ou ruim ¹	
ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA	AVD Instrumental	3. Por causa da sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras? () Sim ⁴ () Não ou não faz compras por outros motivos que não a saúde.	Máximo 4 pts
		4. Por causa da sua saúde ou condição física, você deixou de controlar seu dinheiro, gastos ou pagar as contas da casa? () Sim ⁴ () Não ou não contra o dinheiro por outros motivos que não a saúde.	
		5. Por causa da sua saúde ou condição física, você deixou de realizar pequenos trabalhos domésticos, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve? () Sim ⁴ () Não ou não faz pequenos trabalhos domésticos por outros motivos que não a saúde.	
	AVD Básica	6. Por causa da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho? () Sim ⁶ () Não	
COGNIÇÃO	7. Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido? () Sim ¹ () Não		
	8. Este esquecimento está piorando nos últimos meses? () Sim ¹ () Não		
	9. Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano? () Sim ² () Não		
HUMOR	10. No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança? () Sim ² () Não		
	11. No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas? () Sim ² () Não		
MOBILIDADE	Alcance, preensão e pinça	12. Você é incapaz de elevar os braços acima do nível do ombro? () Sim ¹ () Não	
		13. Você é incapaz de manusear ou segurar pequenos objetos? () Sim ¹ () Não	
	Capacidade aeróbica e/ou muscular	14. Você tem alguma das quatro condições abaixo relacionadas? - Perda de peso não intencional de 4,5kg ou 5% do peso corporal no último ano ou 6kg nos últimos 6 meses ou 3kg no último mês () ; - Índice de Massa Corporal (IMC) menor que 22kg/m² () ; - Circunferência da panturrilha < 31cm () ; - Tempo gasto no teste de velocidade da marcha (4m) > 5 segundos () . () Sim ² () Não	Máximo 2 pts
		Marcha	
	16. Você teve duas ou mais quedas no último ano? () Sim ² () Não		
Continência Esfíncteriana	17. Você perde urina ou fezes, sem querer, em algum momento? () Sim ² () Não		
COMUNICAÇÃO	Visão	18. Você tem problemas de visão capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? É permitido uso de óculos ou lentes de contato. () Sim ² () Não	
	Audição	19. Você tem problemas de audição capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? É permitido o uso de aparelhos de audição. () Sim ² () Não	
COMORBIDADES MÚLTIPLAS	Polipatologia	20. Você tem alguma das três condições abaixo relacionadas? - Cinco ou mais doenças crônicas () ; - Uso regular de cinco ou mais medicamentos diferentes, todo dia () ; - Internação recente, nos últimos 6 meses () . () Sim ⁴ () Não	Máximo 4 pts
	Polifarmácia		
	Internação recente (< 6 meses)		

Pontuação final - até 40 pontos

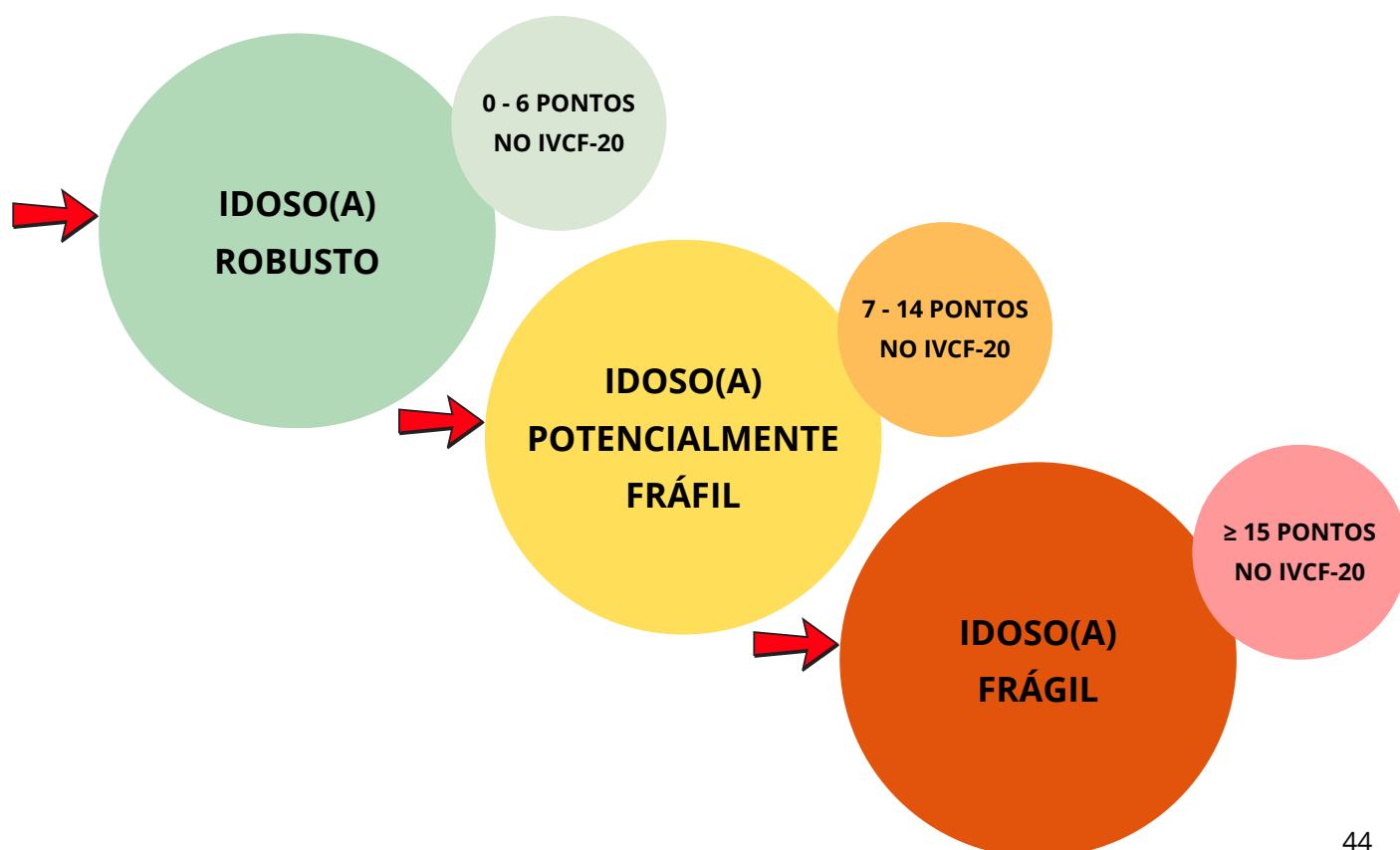
PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

Após a aplicação do instrumento, o avaliador soma os pontos obtidos e define o escore final. Idosos com pontuação igual ou superior a 15 pontos apresentam alto vulnerabilidade clínico-funcional. Idosos com pontuação entre 7 e 14 pontos apresentam moderada de vulnerabilidade clínico-funcional, enquanto que idosos com pontuação entre 0 e 6 pontos apresentam baixa vulnerabilidade clínico-funcional.

Os escores obtidos no IVCF-20 apresentaram alta correlação com a classificação clínico-funcional realizada por equipe geriátrico-gerontológica especializada. Desta forma, podemos considerar que idosos com baixa vulnerabilidade clínico-funcional são “robustos”, enquanto que idosos com moderada e alta vulnerabilidade podem ser considerados “em risco de fragilização” (pré-frágeis) e “frágeis”, respectivamente (MORAES, 2023).

CORRELAÇÃO ENTRE RISCO DE VULNERABILIDADE E DECLÍNIO FUNCIONAL

0 - 6 PONTOS	IDOSOS COM BAIXO RISCO DE VULNERABILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL	AUSÊNCIA DE DECLÍNIO FUNCIONAL
7 - 14 PONTOS	IDOSOS COM MODERADO RISCO DE VULNERABILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL	POSSÍVEL DECLÍNIO FUNCIONAL
≥ 15 PONTOS	IDOSOS COM ALTO RISCO DE VULNERABILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL	PRESENÇA DE DECLÍNIO FUNCIONAL



PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

ENVELHECIMENTO FISIOLÓGICO (SENESCÊNCIA)		ENVELHECIMENTO PATOLÓGICO (SENILIDADE)		
AUSÊNCIA DE DECLÍNIO FUNCIONAL	DECLÍNIO FUNCIONAL IMINENTE	DECLÍNIO FUNCIONAL ESTABELECIDO		
		AVD INSTRUMENTAL		AVD BÁSICA
		DEPENDÊNCIA PARCIAL	DEPENDÊNCIA TOTAL	SEMIDPENDÊNCIA DEPENDÊNCIA INCOMPLETA DEPENDÊNCIA COMPLETA

Assim como o processo de envelhecimento, o conceito de fragilidade também é heterogêneo, pois tenta abarcar diversas condições de saúde associadas a desfechos adversos e que, portanto, necessitam de reconhecimento precoce e de intervenções capazes de impedir ou retardar seu desenvolvimento. Em termos de saúde pública, segundo Moraes (2023, p.19) fragilidade pode ser assim definida:

“Condição crônica de saúde resultante do declínio da capacidade homeostática sistêmica e celular. Não é uma doença propriamente dita, mas sim, um processo patológico associado ao acúmulo de agressões ao meio interno do organismo, não só relacionadas ao envelhecimento, mas também ao estilo de vida, hábitos, fatores de risco e ambientais. Apresenta caráter dinâmico, multidimensional, progressivo, mas potencialmente modificável, caracterizado pela redução significativa das reservas homeostáticas e, conseqüentemente, maior vulnerabilidade a desfechos adversos, como progressão rápida do declínio funcional, quedas, reações adversas a medicamentos (RAM), internação, institucionalização e óbito”.

Seu reconhecimento exige o pensamento sistêmico, que consiste na visão holística dos determinantes da saúde, definida como a capacidade individual de satisfação das necessidades biopsicossociais, independentemente da idade ou da presença de doenças. Nesta perspectiva, fragilidade não é também um somatório de doenças, mas representa o resultado das interconexões entre diversas condições crônicas de saúde mais prevalentes nesta população, cuja importância individual é inquestionável, mas que, quando associadas, podem causar profundas consequências na autonomia e independência da pessoa idosa. Idosos frágeis são mais vulneráveis às condições crônicas e mais susceptíveis às condições agudas, como doenças infecciosas e causas externas, como quedas (MORAES, 2023).

O IVCF-20 é uma forma de operacionalização desse pensamento sistêmico na área da saúde da pessoa idosa, com enfoque maior na funcionalidade global do indivíduo e não no diagnóstico de condições específicas de saúde. Nessa população, a fragmentação diagnóstica deve ser cuidadosa, pois a interrelação entre as doenças é mais importante do que as doenças em si. Assim, o tema fragilidade deve ser encarado nesta perspectiva sistêmica, que implica na capacidade de cada profissional/equipe de saúde, em compreender realmente o indivíduo como um todo, para muito além de doenças, em sua integralidade e historicidade. As intervenções propostas para os idosos frágeis devem ser, portanto, holísticas e interdisciplinares, e a atenção primária à saúde (APS) o ponto da rede mais apropriado para tal abordagem (MORAES, 2023).

FACILIDADES E UTILIDADES DO IVCF-20:

- Possibilita a identificação da pessoa idosa frágil por profissionais de saúde não especialistas em geriatria/gerontologia;
- Permite a gestão da população de risco, com elaboração de políticas públicas específicas, conforme diagnóstico populacional e situacional;
- Facilita o planejamento da demanda programada, por meio de definição de grupos de idosos que necessitem de atendimento diferenciado na Atenção Primária em Saúde;
- Permite a padronização de critérios de compartilhamento do cuidado para a Atenção Ambulatorial Especializada;
- Permite a identificação de sintomas ou problemas de saúde que merecem intervenções específicas, como a suspeita de incapacidade cognitiva (demência), transtorno de humor, ombro doloroso, afecções nas mãos, sarcopenia, quedas, aletarção na marcha, incontinência esfinteriana, alterações da visão e da audição, polifarmácia, entre outras;
- Permite a prescrição de intervenções preventivas, promotores, paliativas e/ou reabilitadoras individualizadas, conforme o estrato clínico-funcional da pessoa idosa, capazes de melhorar sua autonomia e independência e de prevenir o declínio funcional;
- Elaboração de um plano de cuidado e/ou plano de autocuidado com base nas necessidades reais da pessoa idosa e sua família;
- Destaca as dimensões da saúde da pessoa idosa que merecem investigação mais detalhada;
- Permite o reconhecimento das demandas;
- É um instrumento simples e de rápida aplicação (5 a 10 minutos);
- Cada seção é avaliada através de perguntas simples, que podem ser respondidas pelo idoso ou por alguém que conviva com ele;
- Deve ser utilizado rotineiramente para a estratificação de risco da pessoa idosa;
- É reconhecido mundialmente como um dos quatro melhores instrumentos capazes de reconhecer o idoso frágil.

O rastreamento de risco do idoso por meio do IVCF-20 deve ser complementado pela avaliação multiprofissional e interdisciplinar, envolvendo os profissionais da equipe médica e de enfermagem, equipes multiprofissionais na APS (e-multi) e saúde bucal.

Esta avaliação consiste na realização de avaliação clínica tradicional, avaliação sociofamiliar e detalhamento das AVD.

A avaliação clínica tradicional consiste na realização da anamnese e do exame físico do idoso, com foco na avaliação dos sistemas fisiológicos principais e de outras funções orgânicas, como sono, nutrição e saúde bucal. A avaliação sociofamiliar consiste na identificação e na caracterização dos principais fatores de risco determinantes da saúde do idoso, por meio da aplicação do instrumento Avaliação da Fragilidade Sociofamiliar. O instrumento contém itens que avaliam a gravidade do suporte familiar e social, com pontuação que indica desde a ausência de gravidade (zero ponto) até uma situação grave (≥ 10 pontos). Quanto maior a pontuação, maior a fragilidade sociofamiliar (SBIBAE, 2019).

O detalhamento das AVD avalia a capacidade do idoso para a realização das ABVD (tomar banho, vestir-se, uso do vaso sanitário, transferência, continência e alimentar-se) e das AIVD (preparar refeições, tomar remédios, fazer compras, controlar o dinheiro, usar o telefone, arrumar a casa, lavar e passar roupa e sair de casa sozinho), resultando na avaliação de independência, dependência parcial ou completa. Esse detalhamento possibilita a identificação dos sinais de declínio funcional. As AAVD são relacionadas às atividades produtivas, de lazer e de socialização e absolutamente individuais, sendo difíceis de serem padronizadas para comparação entre os idosos. Sua maior utilidade é o reconhecimento precoce de alterações na funcionalidade global do idoso (SBIBAE, 2019).



A avaliação sociofamiliar e o detalhamento das AVD são recomendados para os usuários com IVCF-20 com pontuação final ≥ 7 pontos.

COMO LANÇAR O IVCF-20 NO e-SUS?

Como destacado, o **IVCF-20** é o instrumento recomendado pela **Coordenação Regional da Política de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa da 4ªCRS/SES/RS** para avaliação da funcionalidade global da pessoa idosa.

Desta forma, após ser aplicado, pode e deve ser registrado por um profissional de nível superior na plataforma e-SUS. O lançamento deve ser feito por um único profissional, mesmo que a avaliação tenha sido feita por toda equipe.

Número procedimento: 03.01.09.003-3 **Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa**

Idosa Teste | Feminino
66 anos e 4 meses | Nasceu em 23/05/1956 CPF CNS — Nome da mãe Mãe Idosa Teste

Folha de rosto **SOAP** Histórico Vacinação Cadastro do cidadão Agendamentos

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados

CIAP 2
SIGTAP

AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA - 0301090033

Prescrição de medicamentos Solicitação de exames Atestados Orientações Encaminhamentos

Fonte: Guia RBC/RS - Registro de Avaliação Multidimensional

A Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa é um dos indicadores de pactuação estadual. É necessário que a avaliação seja registrada de forma adequada no e-SUS para que seu município atinja o percentual pactuado anualmente. Verifique junto a gestão municipal qual foi o percentual pactuado para este ano em seu município.

COMO REGISTRAR A AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL NO e-SUS?

O novo webinar “Atualiza e-SUS APS” marcará o lançamento da funcionalidade “Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional” no prontuário eletrônico das equipes multiprofissionais do SUS.

Clique no link e conheça o passo a passo de como realizar o registro:

<https://www.youtube.com/live/vHZBE7l7rJw>



1º Webinar da 2ª Temporada da série Atualiza e-SUS APS

COMO BUSCAR SEU MUNICÍPIO NO SISAB?

Número procedimento: 03.01.09.003-3
Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa



Monitoramento dos registros inseridos no PEC/e-SUS:

1. Saúde e Produção;
2. Selecionar as competências a serem monitoradas (meses e ano);
3. Selecionar na linha de relatório: município;
4. Selecionar na coluna do relatório: competência;
5. Selecionar no tipo de produção: Procedimento;
6. Clicar em **+SIGTAP** e selecionar "Avaliação multidimensional da Pessoa Idosa";
7. Para visualizar selecionar a opção de preferência (tabelas, excel, gráfico).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CLÍNICO-FUNCIONAL; E ESTRUTURAÇÃO DO CUIDADO OFERTADO ÀS PESSOAS IDOSAS CONFORME SUAS NECESSIDADES, DE ACORDO COM O ESTRATO DE RISCO, NA REDE LOCORREGIONAL DE SAÚDE.

A estratificação de risco da pessoa idosa é o resultado da aplicação do IVCF-20, avaliação clínica tradicional, avaliação sociofamiliar e detalhamento das AVD, quando indicado. Contudo, neste Plano Regional, vamos focar no IVCF-20, pois é um instrumento mais simples e mais rápido, podendo ser aplicado por qualquer profissional da APS, incluindo o agente comunitário de saúde (ACS) e tem a vantagem de permitir a **estratificação de risco global da pessoa idosa** em três estratos (baixa, moderada e alta vulnerabilidade clínico-funcional), permitindo a utilização do modelo da Pirâmide de Riscos, recomendada para o manejo de condições crônicas de saúde na Atenção Primária em Saúde (MORAES, 2023).

Mas para fins de conhecimento e refletindo que o Plano Regional para o Cuidado à Pessoa Idosa e as Pessoas com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, tem foco na Atenção Primária à Saúde INTEGRADA à Atenção Ambulatorial Especializada, tratar-se-á, portanto, também do conceito de Avaliação Geriátrica Ampla (AGA). A Avaliação Geriátrica Ampla é definida como um procedimento diagnóstico e terapêutico, com caráter multidimensional e interdisciplinar com o objetivo de avaliar as capacidades física, funcional, psicológica e social do indivíduo, a fim de desenvolver um plano de cuidados coordenado e integrado para o tratamento e acompanhamento a longo prazo (MORAES, 2023).

A AGA é, portanto, um instrumento realizado por equipes geriátrico-gerontológicas especializadas, que são pouco disponíveis na RAS. No entanto, nas regiões de Saúde Verdes Campos e Entre Rios, do estado do Rio Grande do Sul, o Ambulatório de Condições Crônicas para Adultos e Pessoas Idosas do Hospital Regional de Santa Maria e, o Ambulatório de Geriatria do Hospital Universitário de Santa Maria fazem parte da rede locorregional, realizando a Avaliação Geriátrica Ampla nas pessoas idosas que tem seu cuidado compartilhado entre a APS e a AAE.

Assim, a estratégia proposta neste material é a utilização desses instrumentos, conforme a necessidade da pessoa idosa e a disponibilidade de recursos humanos.

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

A definição do estrato clínico-funcional baseia-se na funcionalidade (dependência ou independência para AAVD, AIVD e ABVD) e na presença de fatores de risco, doenças e comorbidades múltiplas, pois, além da heterogeneidade funcional, os idosos também apresentam diferenças quanto à complexidade clínica e à necessidade de acompanhamento geriátrico-gerontológico especializado (SBIBAE, 2019; MORAES, 2023).

As definições de AVD são apresentadas a seguir (RIO GRANDE DO SUL, 2022):

a) Atividades Básicas da Vida Diária: tarefas relacionadas ao autocuidado, como tomar banho sozinho, vestir-se sem ajuda, usar o banheiro, deitar-se e sair da cama sozinho (transferência), controle de esfíncter (urina e fezes) e alimentar-se sozinho.

b) Atividades Instrumentais da Vida Diária: tarefas necessárias para o cuidado com o domicílio ou atividades domésticas, como o preparo das refeições, controle do dinheiro e do pagamento de contas, tomar os remédios na dose e horário correto, lavar e passar a roupa, uso do telefone, arrumar a casa e fazer pequenos trabalhos domésticos, fazer compras e sair de casa sozinho para lugares distantes.

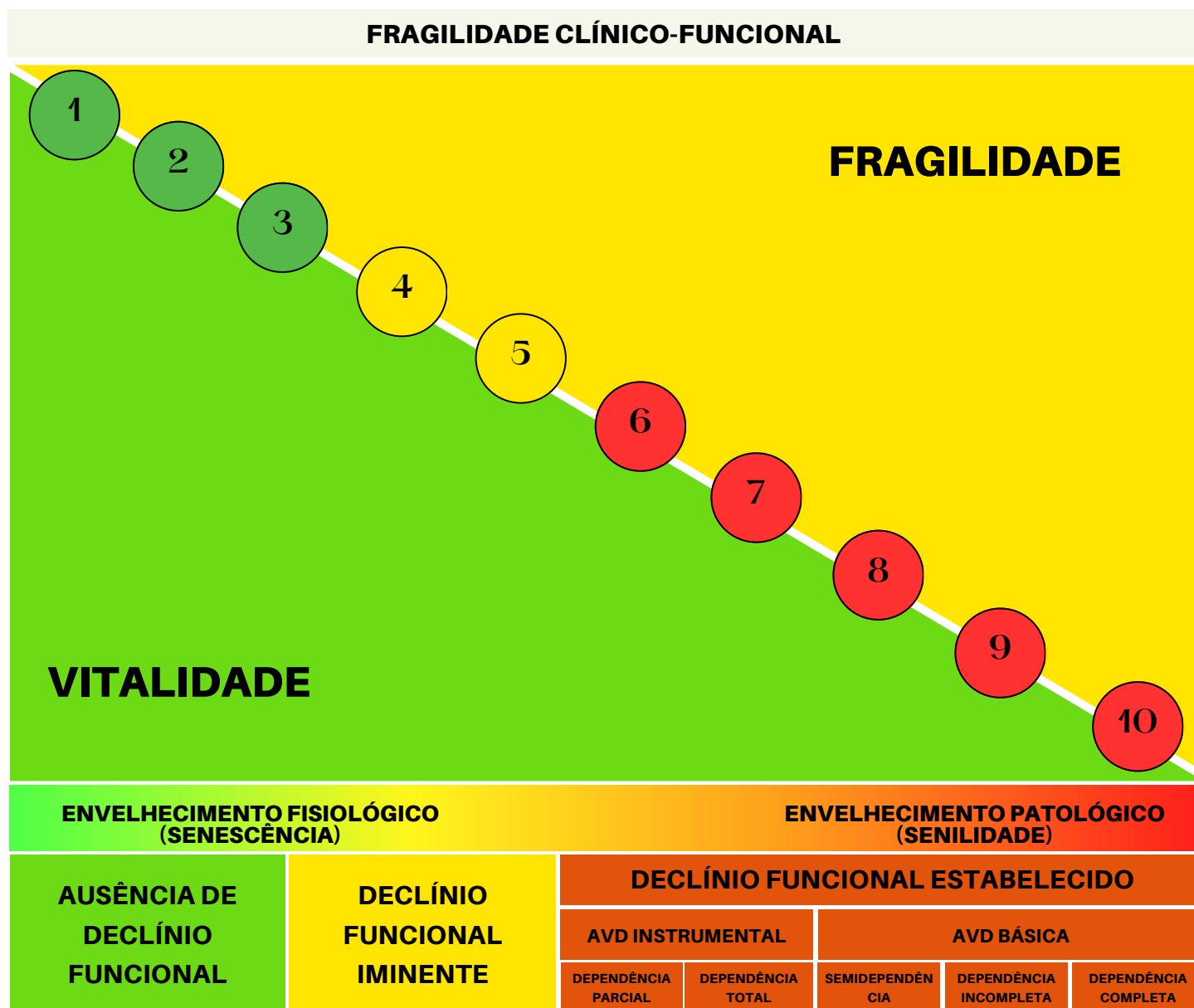
c) Atividades Avançadas de Vida Diária: atividades mais complexas, relacionadas à integração social, como as atividades produtivas, recreativas e de participação social.

A Escala Visual de Fragilidade apresenta os extremos opostos da capacidade funcional, representando o grau máximo e mínimo de vitalidade (capacidade intrínseca) e de fragilidade (vulnerabilidade), ligando-os por uma linha reta e contínua, mas declinante, do ponto de máxima vitalidade e mínima vulnerabilidade, até o ponto de mínima vitalidade e máxima vulnerabilidade. Nesse percurso, podem ser identificados dez estratos ou categorias clínico-funcionais do processo de envelhecimento.

Idosos portadores de comorbidade múltipla, sarcopenia e/ou comprometimento cognitivo leve são classificados como **“idoso em risco de fragilização”**. A presença de declínio funcional nas atividades de vida diária instrumentais (controle financeiro, fazer compras, preparar refeição, sair sozinho, realizar trabalhos domésticos, etc) caracteriza a fragilidade moderada. Nesta condição, o idoso é classificado como **“idoso frágil”**. A presença de incapacidade funcional para a realização das atividades básicas de vida (tomar banho, vestir-se, usar o banheiro, fazer transferência ou alimentar-se sozinho) caracteriza a fragilidade grave. Por fim, idosos que não apresentam declínio funcional, comorbidade múltipla, sarcopenia ou comprometimento cognitivo leve são denominados de **“idosos robustos”**. Estes últimos podem ter, inclusive, doenças, como hipertensão arterial, diabetes, etc, ou terem idade avançada, mas são independentes para todas as atividades de vida diária (MORAES, 2023).

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

Figura 05 - Escala de Fragilidade Clínico-Funcional



Os dez estratos ou categorias clínico-funcionais são agrupados em três grandes grupos de idosos: idoso robusto (estratos 1 a 3), em risco de fragilização (estratos 4 e 5) e frágil (estratos 6 a 10).

A gravidade da fragilidade variável, podendo ser leve, quando não há declínio funcional, como ocorre na presença de comorbidade múltipla, sarcopenia ou comprometimento cognitivo leve. Comorbidade múltipla é, por sua vez, uma condição crônica de saúde caracterizada pela presença de várias doenças ou condições de saúde simultaneamente no mesmo indivíduo (polipatologia), associadas ou não ao uso regular e diário de cinco ou mais medicamentos (polifarmácia). A presença de internação recente, nos últimos seis meses, também incluída nesta condição de saúde, pois está associada a alto risco de declínio funcional, independentemente da causa.

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

A sarcopenia é outra condição crônica de saúde caracterizada pela redução da força e/ou da massa muscular, que pode também evoluir para declínio funcional e outros desfechos adversos. O comprometimento cognitivo leve caracterizado pela presença de declínio cognitivo objetivo, mas sem repercussão funcional evidente, mas que apresenta alto risco de evolução para demência.

Quadro 4 - Estratificação de risco da pessoa idosa

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DA PESSOA IDOSA			
FRAGILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL	ESTRATOS CLÍNICOS-FUNCIONAIS (IVCF-20)	CARACTERÍSTICAS	PARÂMETRO DE PREVALÊNCIA (20,15% pop. idosa do RS)
IDOSO ROBUSTO Ausência de declínio funcional, mesmo na presença de doenças crônicas.	ESTRATO 1	Independentes para todas as AVD. Sem doença crônica.	50% da população idosa do território
	ESTRATO 2	Independentes para todas as AVD. Doença crônica simples.	
	ESTRATO 3	Independentes para todas as AVD. Doença crônica complexa.	
IDOSO EM RISCO DE FRAGILIZAÇÃO Declínio funcional iminente.	ESTRATO 5	Independentes para todas as AVD. Redução de força muscular. Comprometimento Cognitivo Leve. Comorbidades múltiplas.	30% da população idosa do território
	ESTRATO 4	Independentes para todas as AIVD e ABVD. Limitações nas AAVD. Sarcopenia. Redução de força muscular.	
IDOSO FRÁGIL Declínio funcional estabelecido.	ESTRATO 6	Independentes para as ABVD; Declínio funcional parcial para as AIVD (dependência parcial).	20% da população idosa do território
	ESTRATO 7	Independentes para as ABVD; Declínio funcional total para as AIVD (dependência completa).	
	ESTRATO 8	Dependência Completa AIVD; Dependência parcial para as ABVD.	
	ESTRATO 9	Dependência Completa AIVD. Dependência incompleta para as ABVD (preservada capacidade de alimentar-se sozinho).	
	ESTRATO 10	Dependência completa para todas as ABVD. GRAU MÁXIMO DE FRAGILIDADE.	

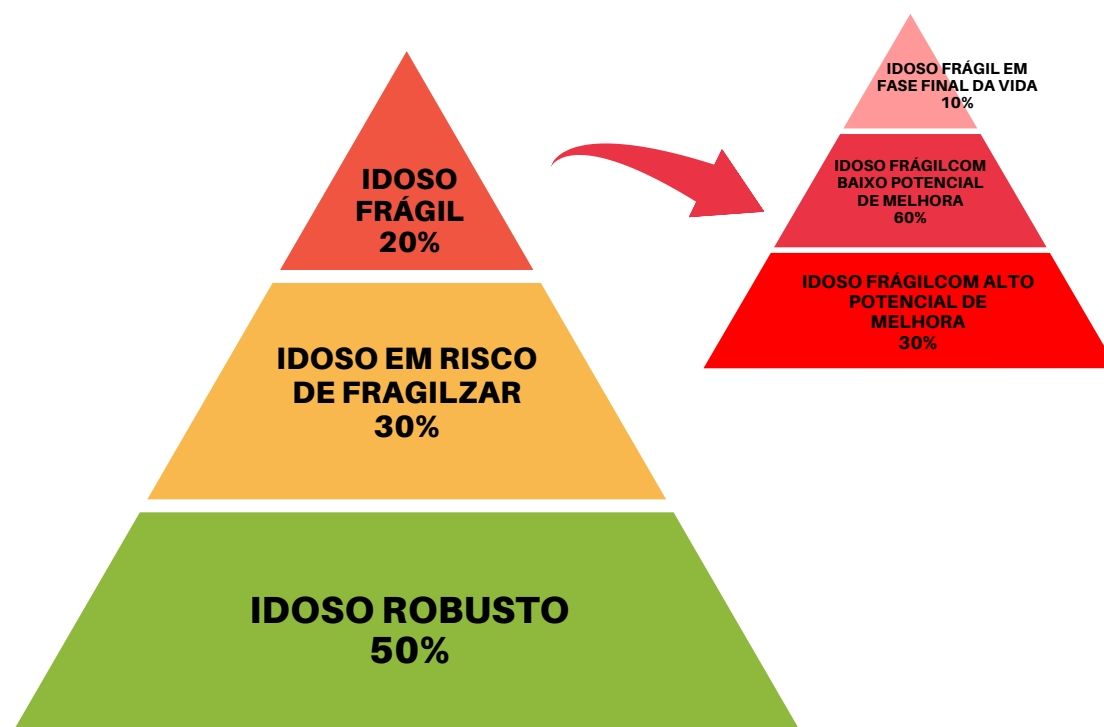
Adaptado de SBIBAE, 2019; Rio Grande do Sul, 2022.

O idoso frágil é aquele com declínio funcional estabelecido e algum grau de dependência para gerenciar sua vida, em virtude de incapacidades únicas ou múltiplas. Esse grupo se divide em três subgrupos, de acordo com a probabilidade de melhora funcional e/ou qualidade de vida:

- **Idoso frágil com alto potencial de melhora funcional:** são idosos com maior probabilidade de ganho funcional e/ ou qualidade de vida, beneficiando-se do acompanhamento geriátrico-gerontológico especializado integrado com a APS.

- **Idoso frágil com baixo potencial de melhora funcional:** são idosos que apresentam declínio funcional estabelecido e baixo potencial de reversibilidade clínico-funcional. Nesses idosos, o acompanhamento geriátrico-gerontológico especializado não necessita ser feito de forma intensiva. Este subgrupo deve ser manejado na APS, com apoio da AAE em saúde do idoso quando necessário, com o objetivo de evitar a piora funcional.
- **Idoso frágil em fase final de vida:** apresenta grande dependência funcional e sobrevida estimada menor que 6 meses ou que tem resposta negativa à seguinte pergunta: “Você ficaria surpreso se o paciente falecesse nos próximos meses, semanas ou dias?”.

Apesar da existência de uma clara associação entre maior grau de declínio funcional e maior mortalidade, alguns idosos podem estar relativamente preservados funcionalmente e apresentar doenças com alto potencial de mortalidade, como determinados tipos de neoplasia, por exemplo. Este subgrupo também deve ser manejado na APS, com apoio da AAE em saúde do idoso quando necessário, tendo como foco das intervenções o cuidado paliativo, baseado no conforto do usuário e de seus familiares (SBIBAE, 2019; MORAES, 2023).



Fonte: SBIBAE, 2019.

Nesta classificação clínico-funcional, estima-se que a maior parte dos idosos (cerca de 50%) é considerada robusta, necessitando de pequenos ajustes na atenção à saúde, particularmente no que se refere à prescrição de intervenções fúteis ou potencialmente iatrogênicas. Cerca de 20% dos idosos são frágeis e necessitam de respostas diferenciadas para suas demandas de saúde, definidas de maneira compartilhada pela AAE e APS. O terceiro grupo, idosos com risco de fragilização ou pré-frágeis, representa cerca de 30% da população idosa e deve ser monitorado rigorosamente pela APS, pois estão em risco de adquirirem incapacidades funcionais (RIO GRANDE DO SUL, 2022).

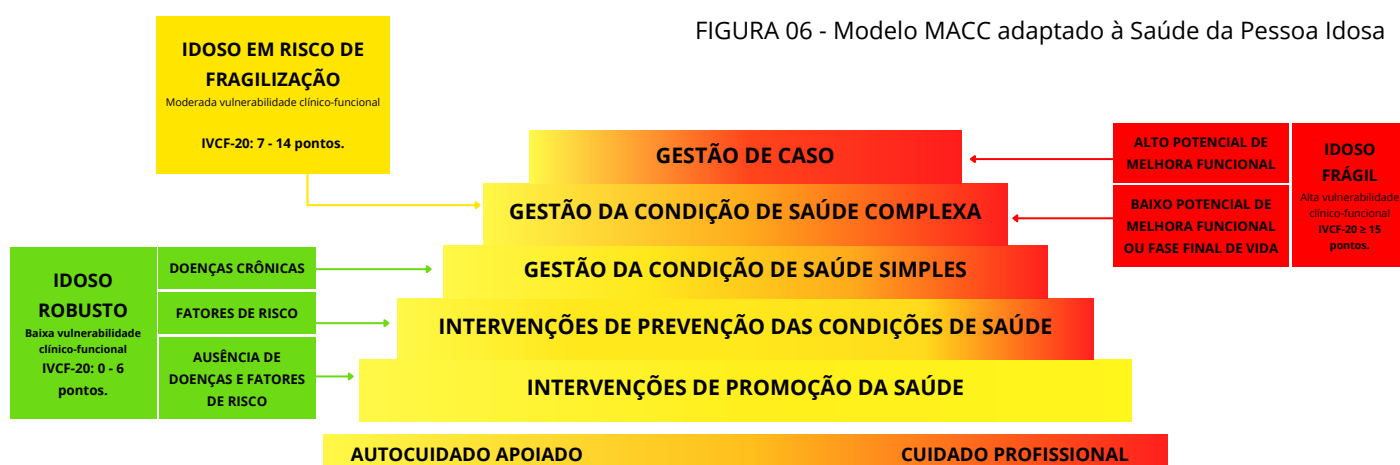
ESTRUTURAÇÃO DO CUIDADO À PESSOA IDOSA:

O cuidado oferecido aos idosos, especialmente àqueles portadores de múltiplas condições crônicas de saúde, poli-incapacidades ou necessidades complexas, é frequentemente fragmentado, ineficiente, ineficaz e descontínuo, podendo agravar ainda mais sua condição de saúde. Contrariamente, as evidências atuais mostram que a atenção à saúde dos idosos mais frágeis, com qualidade, resolutividade e custo-eficácia, deve ser associada a quatro princípios essenciais, que superam o simples diagnóstico e tratamento das doenças individuais:

- **Avaliação multidimensional ou abrangente**, que reconheça todas as demandas biopsicossociais do usuário, seus valores, crenças, sentimentos e preferências para o cuidado.
- **Elaboração, implementação e monitoramento do plano de cuidados**, composto por todas as intervenções preventivas, curativas, paliativas e reabilitadoras, definidas de forma compartilhada.
- **Comunicação e coordenação** com todos os profissionais e serviços necessários para implementação do plano de cuidados, com ênfase no cuidado transicional.
- **Promoção do engajamento ativo do usuário** e sua família no cuidado com sua saúde.

Esses princípios, junto com a estratificação de risco, são pressupostos básicos para o Modelo de Atenção às Condições Crônicas de saúde (MACC), além de serem estratégias para gestão de base populacional, que deve ser programada por parâmetros das necessidades da população, com foco nas demandas populacionais discriminadas segundo riscos sociais e sanitários de subpopulações e soluções que equilibram o incremento da oferta e a organização das demandas (MENDES, 2019).

FIGURA 06 - Modelo MACC adaptado à Saúde da Pessoa Idosa

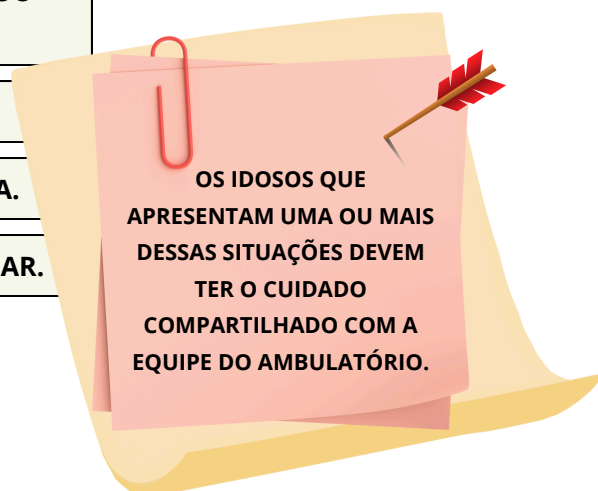


ACOMPANHAMENTO LONGITUDINAL DA PESSOA IDOSA:

O acompanhamento longitudinal do idoso deve ser realizado de acordo com o estrato de risco clínico-funcional. **Os idosos robustos (estratos 1 a 3)**, que usualmente têm IVCF-20 ≤ 6 pontos, podem ter seu plano de cuidados elaborado e implementado pela APS. Na presença de doenças crônicas degenerativas, o manejo deve seguir as recomendações das diretrizes clínicas específicas, com atenção para as intervenções potencialmente iatrogênicas, como prescrição de medicamentos inapropriados para o idoso (MORAES, 2023).

Os idosos em risco de fragilização (estratos 4 e 5), que em geral têm IVCF-20 entre 7 e 14 pontos, devem ter seu plano de cuidados elaborado e implementado pela APS, com exceção para as seguintes situações:

SUSPEITA DE INCAPACIDADE COGNITIVA.
PRESENÇA DE INSTABILIDADE POSTURAL OU QUEDAS DE REPETIÇÃO.
PRESENÇA DE SARCOPENIA.
SUSPEITA DE PRESCRIÇÃO INAPROPRIADA.
PRESENÇA DE INSUFICIÊNCIA SOCIOFAMILIAR.



Da mesma maneira, os idosos frágeis (estratos 6 a 10), que, usualmente, têm IVCF ≥ 15 pontos devem ser prontamente agendados para a equipe da Atenção Ambulatorial Especializada.

- O processo do cuidado deve contemplar a multidimensionalidade da saúde do idoso. Assim como a avaliação, a intervenção também é multidimensional. Daí a necessidade de atuação interdisciplinar da equipe multiprofissional na APS.
- O acompanhamento prevê a avaliação clínico-funcional evolutiva, com estratificação de risco a cada atendimento programado, e a elaboração, o monitoramento e a atualização do plano de cuidados ao longo do período de acompanhamento.
- Como todo usuário com condição crônica, **o idoso se beneficia de atendimentos em grupo, como a atenção compartilhada, grupos operativos e grupo de pares**, com exceção daqueles com declínio funcional acentuado.

CRITÉRIOS PARA COMPARTILHAMENTO DO CUIDADO COM A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA:

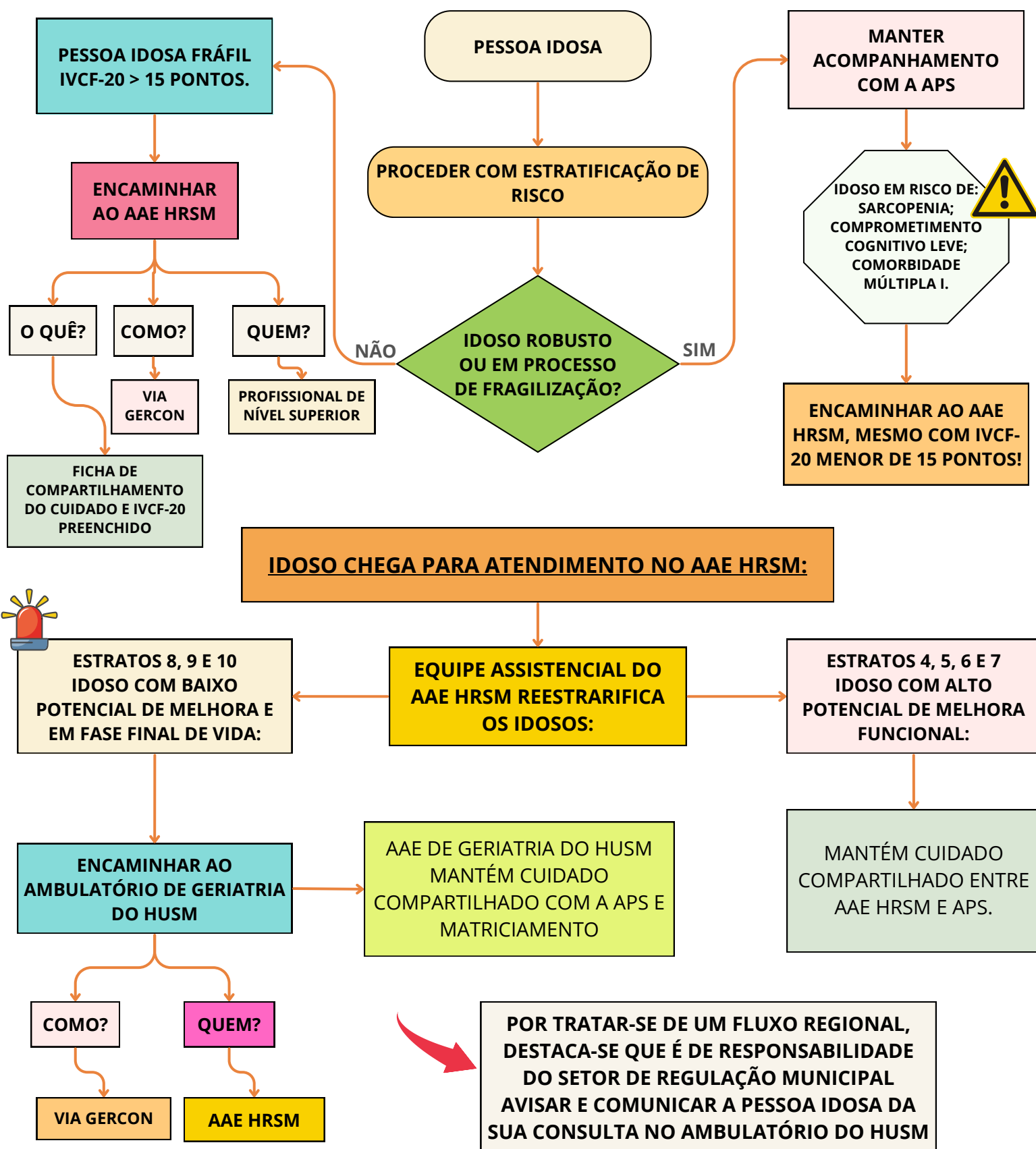
São critérios de encaminhamento para o Ambulatório de Condições Crônicas para Adultos e Pessoas Idosas do Hospital Regional de Santa Maria, aquelas classificadas como pessoa idosa frágil e em risco de fragilização:

- Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF-20) com pontuação mínima de 15 pontos; ou
- Idosos em risco de fragilização com suspeita de incapacidade cognitiva, presença de instabilidade postural e quedas de repetição, suspeita de sarcopenia, suspeita de prescrição inapropriada e presença de insuficiência sociofamiliar (IVCF-20 entre 7 e 14 pontos); e
- Idade mínima de 60 anos.

São critérios de encaminhamento para o Ambulatório de Geriatria do Hospital Universitário de Santa Maria, aquelas classificadas como pessoa idosa frágil com baixo potencial de melhora e em fase final da vida:

- Idosos REESTRATIFICADOS pela equipe assistencial do Ambulatório de Condições Crônicas para Adultos e Pessoas Idosas do HRSM, sendo incluídos nos estratos 8, 9 e 10 (pessoa idosa com baixo potencial de melhora e em fase final de vida); e
- Idade mínima de 60 anos.

FLUXOGRAMA DE COMPARTILHAMENTO DO CUIDADO NA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA PARA AS REGIÕES DE SAÚDE VERDES CAMPOS E ENTRE RIOS



APLIQUEI O IVCF E ESTRATIFIQUEI O RISCO DA PESSOA IDOSA...

Primeiramente, devemos pensar no IVCF-20 como um instrumento norteador de ações para melhoria de vida da pessoa idosa, e não apenas um instrumento para encaminhar o usuário aos ambulatórios.

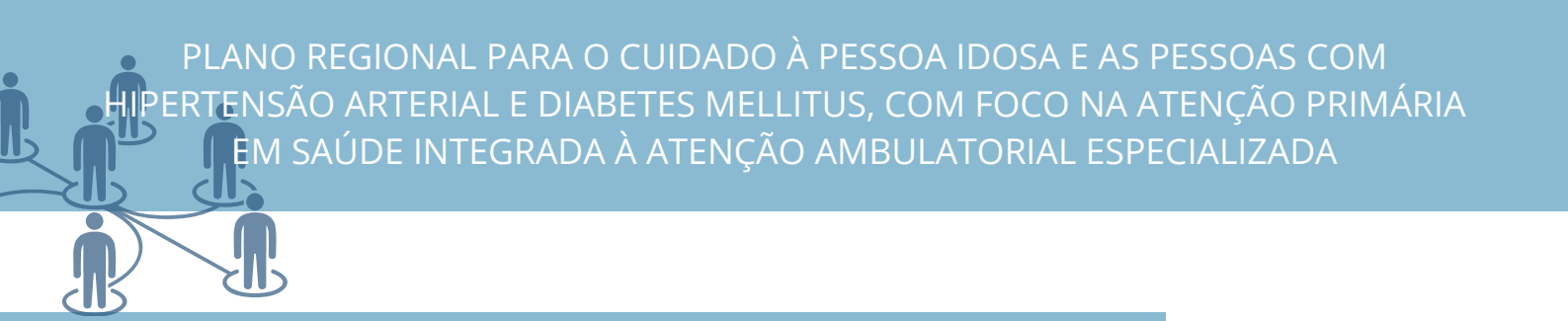
No início deste movimento de cuidar das pessoas idosas do território, muitas dúvidas irão surgir, muitos medos, anseios e inseguranças! E isso significa que, enquanto profissionais humanos, estamos “caminhando” para uma nova etapa da saúde pública regional, estadual, nacional e internacional. Está posta a existência de um transição que ultrapassa as questões demográficas, mas que se amplia para as questões epidemiológicas, nutricionais e tecnológicas. A sociedade está envelhecendo rapidamente, assim como desenvolvemos um novo estilo de vida e nos expomos, cada vez mais, a fatores que contribuem para o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, precocemente. Junto de todo esse cenário, soma-se o fato da explosão tecnológica no setor saúde estar cada vez mais presente no cotidiano comum da vida das pessoas. Exposições, muitas vezes desnecessárias, a exames altamente tecnológicos, repetidas vezes. Para a pessoa idosa, essa exposição, quando desnecessária, é causadora de iatrogenia e dificulta o viver desse indivíduo.

Portanto, o nosso objetivo comum deve ser/estar cristalino. Nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas, porque somos profissionais que tratam e cuidam de pessoas, e este deve ser o sentimento ou ideal romântico a ancorar nossas ações diárias.

Assim, quando aplicado o IVCF-20, analisando-o como um instrumento norteador para melhorar a vida das pessoas idosas e suas famílias, dar-se-á mais atenção para aquelas áreas da vida onde a pessoa está com dificuldades, podendo ser nas AVDs, na cognição, humor, mobilidade, comunicação e/ou comorbidades múltiplas, associadas ou não a vulnerabilidades social e/ou familiar.

E, a partir desta compreensão humanista e holística da pessoa idosa, poderemos elaborar um plano de cuidados e/ou um plano de autocuidado para apoiá-la na manutenção positiva e gerenciamento de sua própria vida.





ELABORAÇÃO DO PLANO DE CUIDADOS DA PESSOA IDOSA

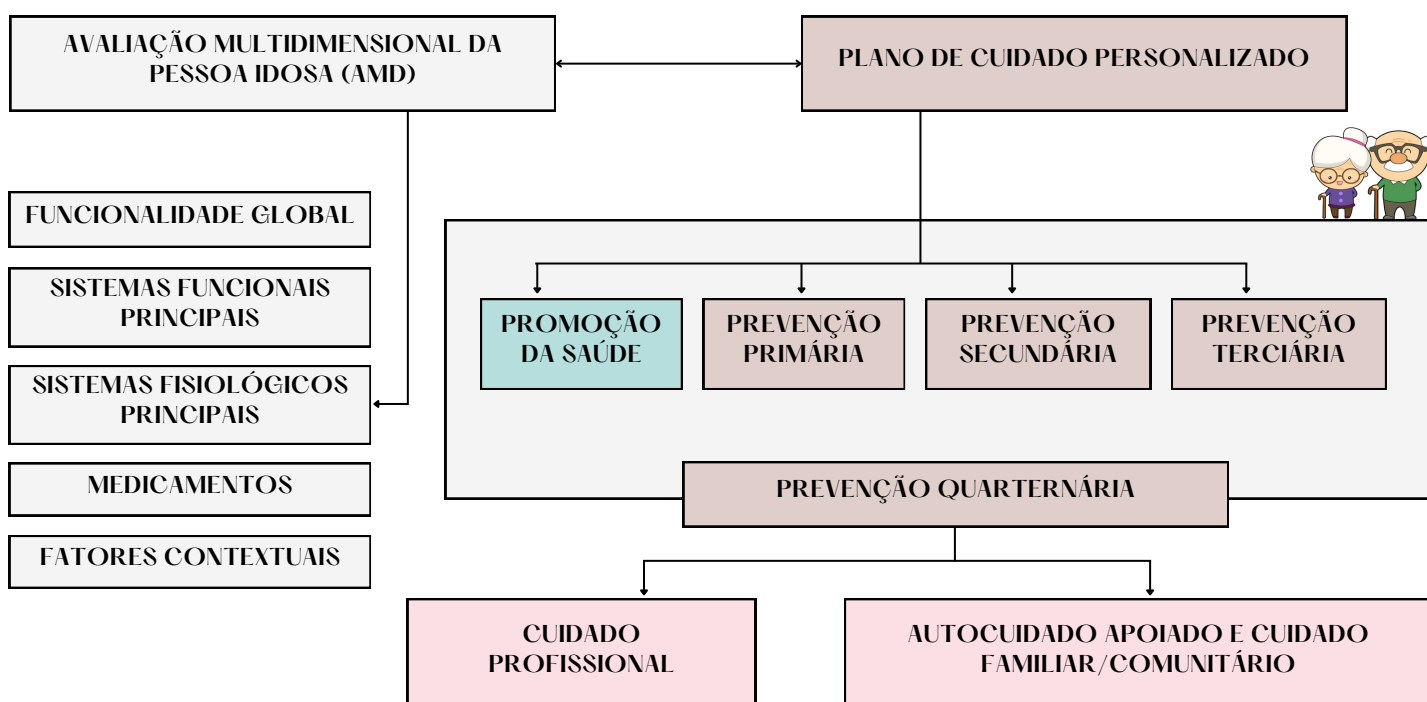
ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS E PROMOCIONAIS NA SAÚDE DA PESSOA IDOSA:

Vale a pena destacar que as estratégias preventivas e promocionais devem ser feitas ao longo de toda vida da pessoa, começando na vida intrauterina. Não há como prevenir o envelhecimento, sendo ele algo irreversível, e deve ser visto como uma conquista. Deve-se focar em como melhorar a vida do sujeito, tanto a vida atual quanto a vida futura, a depender do grau de vitalidade da pessoa idosa.

O ponto de partida para a organização das estratégias preventivas e promocionais é conhecer o modelo multidimensional da saúde da pessoa idosa, bem como a fragilidade multidimensional (fragilidade clínico-funcional e sociofamiliar) e ser capaz de elaborar o plano de cuidados para o usuário em questão.

O plano de cuidados deve conter ações de promoção da saúde, prevenção primária, terciária e quaternária, com a intenção de evitar a iatrogenia. Bem como, devem estar definidas as ações que cabem ao cuidado profissional e as ações que são de autocuidado apoiado e cuidado familiar (no caso dos idosos frágeis que não conseguem cuidar de si).

Figura 07 - visão global do plano de cuidados da pessoa idosa

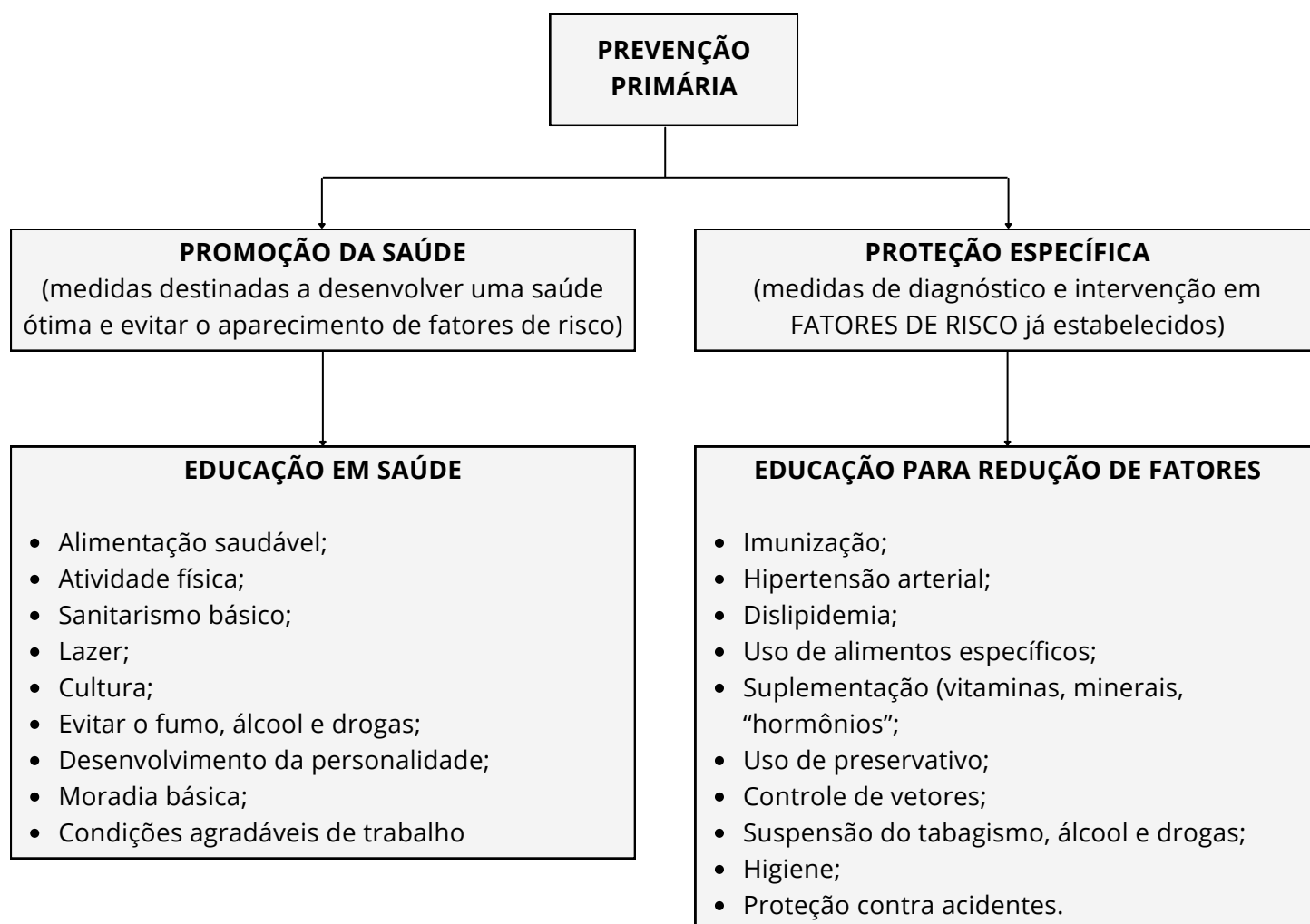


Primeiramente, deve-se conceber o conceito de prevenção como sendo os cuidados antecipatórios. Ou seja, são todas as ações capazes de reduzir à predisposição às doenças ou atrasar o início das manifestações clínicas das doenças e suas complicações, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, limitar o impacto das incapacidades na vida da pessoa idosa e aumentar sua esperança de vida. Resumidamente, significa prever o que vai acontecer com o indivíduo e oferecer alguma ação para que esse processo possa ser retardado.

Nesse contexto, a prevenção primária atua na “predisposição” da doença. Dentro da prevenção primária, está a promoção da saúde, que são medidas destinadas a desenvolver uma saúde ótima e evitar o aparecimento dos fatores de risco, por isso, tem-se que a promoção da saúde é algo que deve ser feito para todas as pessoas. Mas na prevenção primária, o ponto estratégico é a proteção específica, que nada mais é do que o diagnóstico e intervenção em fatores de risco estabelecidos (MENDES, 2019; MORAES, 2023).

Portanto, a promoção da saúde busca evitar os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças, já a proteção específica trabalha com os fatores de risco já estabelecidos:

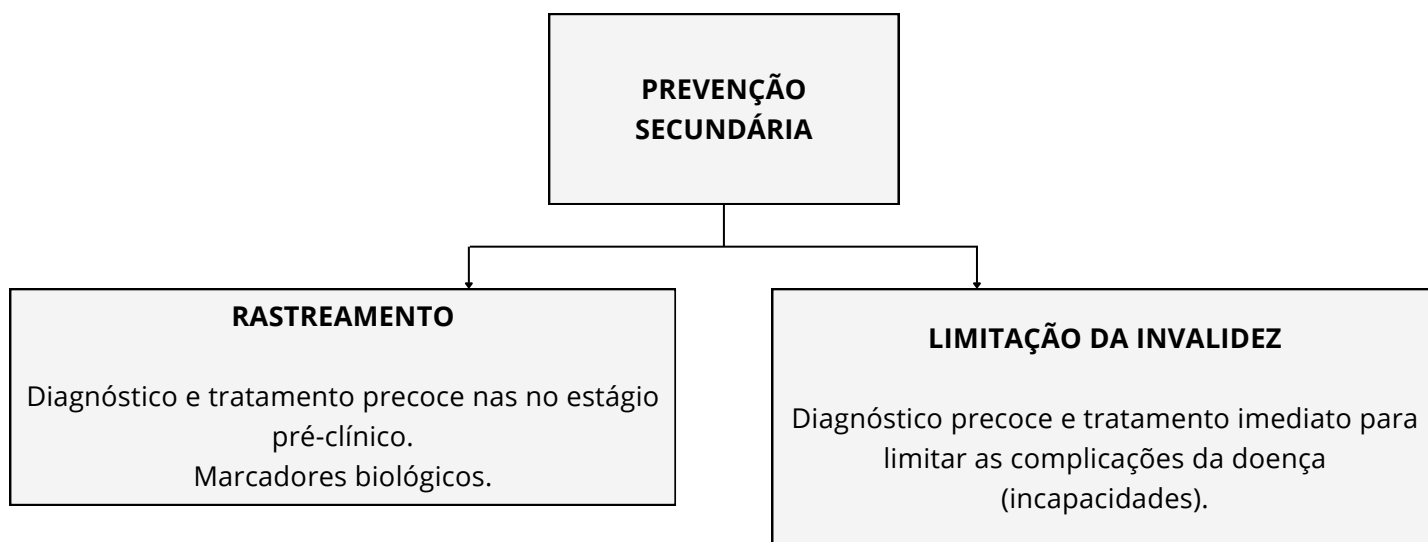
Figura 08 - esquema de prevenção primária à saúde



Já na prevenção secundária **trabalha-se com a doença já instalada**. Tanto na sua fase assintomática, quanto na sua fase sintomática. Quando trabalhamos com a doença na forma assintomática, uma das formas é fazer o rastreamento, como um diagnóstico e intervenção precoce das doenças no estágio pré-clínico. Tentar dar o diagnóstico da doença, antes que ela gere uma manifestação clínica. É trabalhar com os marcadores biológicos (MORAES, 2023).

A prevenção secundária, **trabalhada na fase sintomática da doença, tem por objetivo a limitação da invalidez e incapacidades**.

Figura 09 - esquema de prevenção secundária à saúde



Na **prevenção terciária já há a existência de complicações e incapacidades** na pessoa. Nessa perspectiva, a intenção é reduzir os danos já causados pela doença em questão, logo, o foco da prevenção terciária está na reabilitação e no trabalho intenso multiprofissional e interdisciplinar. Atuação direto nas “incapacidades”.

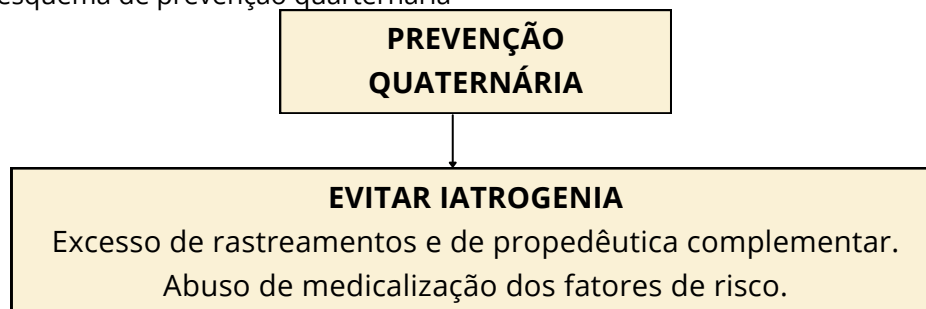
Um exemplo comum na realidade dos serviços da RAS é o atendimento as pessoas vítimas de acidente vascular cerebral/encefálico (AVC/AVE). A intenção da assistência imediata por equipe multiprofissional é a de reabilitação e prevenção das incapacidades que esse AVC pode gerar. Da mesma forma que mantém-se essa postura profissional diante de uma pessoa idosa com fratura de fêmur.

A prevenção quaternária está presente em todos os momentos da história natural da doença, desde a predisposição do indivíduo, até as complicações que podem levar ao óbito e também gerar incapacidades (MORAES, 2023).

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

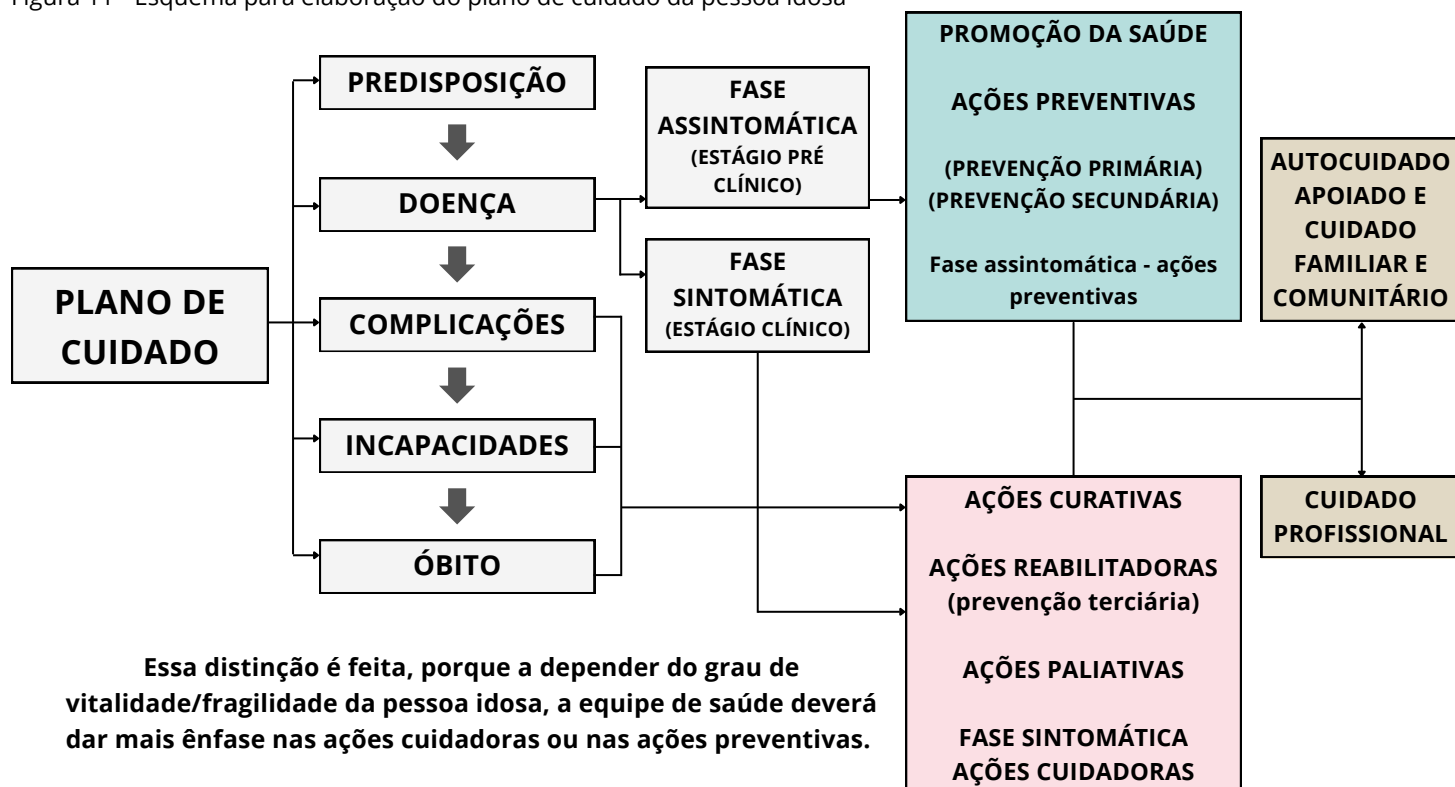
Nada mais é do que a detecção de indivíduos com risco de tratamento excessivo (sobretreatamento - sobrediagnóstico), para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis, para evitar IATROGENIA. Cuida-se, nessa etapa da prevenção, o excesso de cuidados antecipatórios (MORAES, 2023).

Figura 10 - esquema de prevenção quaternária



Assim, nas condições crônicas de saúde, caso o profissional não tem clareza dos benefícios trazidos por determinada intervenção, a melhor escolha é não realizar tal intervenção, a fim de evitar riscos para a saúde do indivíduo. Essa postura deve ser considerada, uma vez que o risco de desencadear outros problemas na saúde são enormes, porque a pessoa idosa, principalmente a pessoa idosa frágil, é/está mais vulnerável, seus mecanismos homeostáticos já não estão mais tão íntegros a ponto e "reverter" os efeitos colaterais das intervenções desnecessárias, como ocorre na pessoa idosa robusta (SBIBAE, 2019; MORAES, 2023).

Figura 11 - Esquema para elaboração do plano de cuidado da pessoa idosa



Elaboração - equipe saúde da pessoa idosa - 4ªCRS/SES/RS.

AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA FORTALECER AS EQUIPES DA APS E DA AAE DA REGIÃO VERDES CAMPOS E ENTRE RIOS DO RIO GRANDE DO SUL

O que é Educação Permanente em Saúde (EPS)?

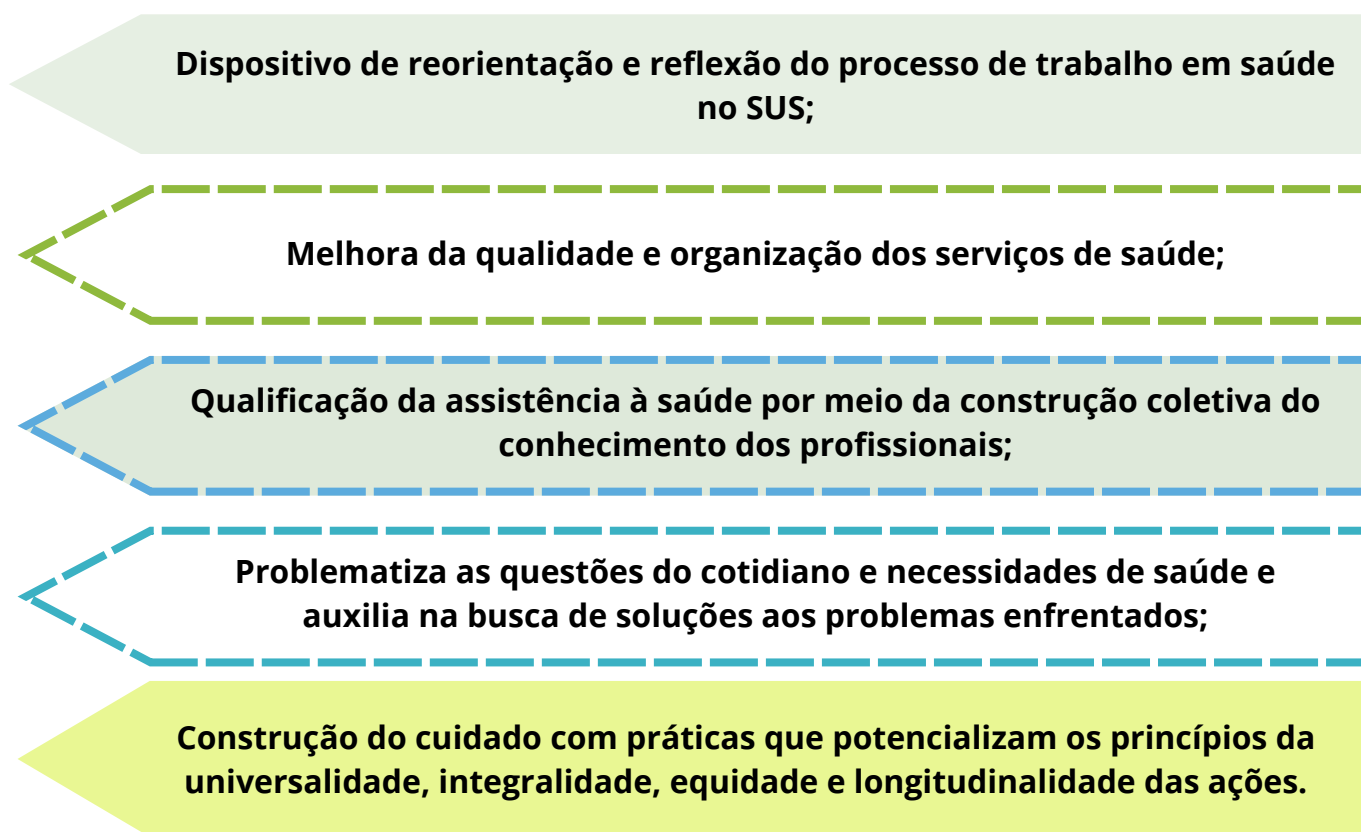
Inserida pelo Ministério da Saúde como uma **política de saúde** por meio das Portarias nº 198/2004 e nº 1996/2007, com o objetivo de **nortear a formação e qualificação dos profissionais** nos serviços públicos de saúde (MORAIS et al., 2024).

Centrada na **aprendizagem significativa**, em que se tem o **processo de trabalho** como **objeto de transformação** das práticas profissionais, a partir da **reflexão crítica** sobre o que está acontecendo no cotidiano dos serviços e as necessidades de saúde (FERREIRA et al., 2019).

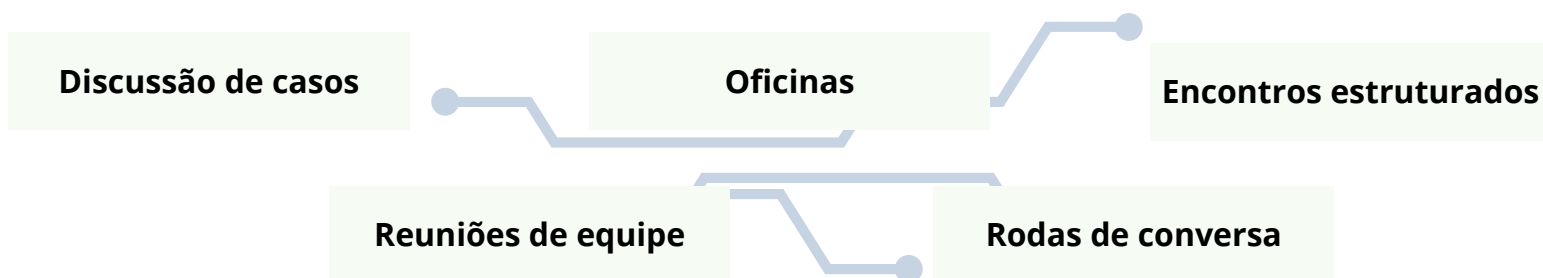
A EPS visa o **fortalecimento** das **práticas** em **APS** e o modelo de atenção à ao considerar o **trabalho articulado** entre as **esferas de gestão**, as **instituições de ensino**, o **serviço** e a **comunidade** (FERREIRA et al., 2019).

Como a educação permanente em saúde (EPS) pode contribuir com a melhoria nos processos de atenção à saúde na APS, em especial da saúde da pessoa idosa e das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis?

PLANO REGIONAL PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA E AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INTEGRADA À ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA



Em quais momentos a EPS pode ser realizada no cotidiano dos serviços de saúde da APS?



O que é Grupo Condutor?

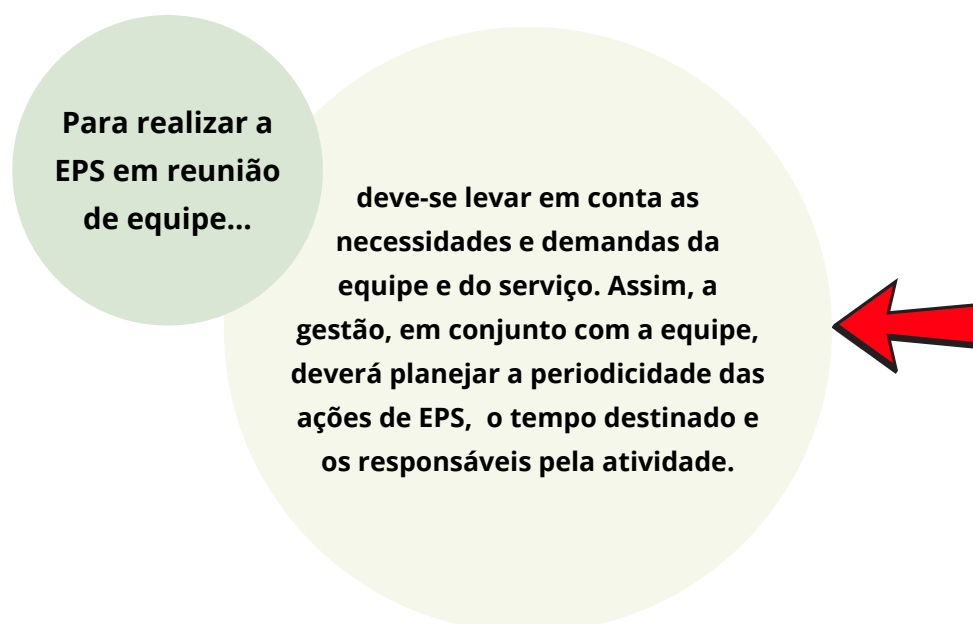
O nome grupo condutor é simbólico e trata-se de oficinas de qualificação, as quais são estratégias potentes de debate coletivo e planejamento de ações acerca de processos de trabalho e de ensino em saúde. Elas devem ser facilitadas por um profissional especialista que disponibilize um espaço de aprendizagem favorável à (re)construção do conhecimento a partir da análise crítica da realidade e da troca de experiências vivenciadas no cotidiano da prática profissional (NASCIMENTO, BADUY, 2021).

As oficinas podem ser desenvolvidas de forma reflexiva e participativa, com foco nas necessidades dos profissionais e da rede de saúde. A constituição de grupos condutores permite a integração ensino-serviço e a construção de parcerias entre diferentes atores envolvidos nos serviços de saúde dos municípios pertencentes a 4º CRS.

O que é Reunião de Equipe e como ela pode colaborar para a EPS?

A reunião de equipe na APS caracteriza-se como espaço de diálogo, com lugar e periodicidade definidos, destinada a construção coletiva e organização do processo de trabalho, ao planejamento, monitoramento e avaliação de ações de saúde, a definição de metas, ao fortalecimento da equipe, a discussão de casos e a tomada de decisões (KASPER et al., 2024).

Destarte, as reuniões de equipe podem potencializar o trabalho de apoio e EPS ao propiciar a aproximação entre diferentes saberes, identificação de lacunas de conhecimento e atitudes, qualificação do processo de trabalho e auxiliar o desenvolvimento do protagonismo e do exercício de autonomia das equipes de saúde frente às realidades locais, considerando a reflexão crítica de suas práticas profissionais (SECRETARIA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2022).



ESTRATÉGIAS DE EPS:

Como a EPS pode qualificar os profissionais de saúde na APS para atuar no cuidado da pessoa idosa e das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ?

Ao Auxiliar a reflexão do processo de trabalho quanto ao contexto socioeconômico e cultural da pessoa idosa e indivíduo com HA e/ou DM;

Ao possibilitar o desenvolvimento de práticas de cuidados que considerem os aspectos multidimensionais da saúde da pessoa idosa;

Ao potencializar a trocas de saberes para reorganizar o cuidado da pessoa idosa e das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis;

Ao empoderar os profissionais quanto a abordagem do autocuidado apoiado, prevenção de agravos clínicos e adoção de hábitos saudáveis;

Ao aprimorar o conhecimento dos profissionais quanto a estratificação de risco, possibilitando criar planos de cuidado e intervenções conforme as reais necessidades e demandas de saúde.

AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

O que é Educação em Saúde?

A Educação em Saúde constitui-se como um instrumento de **construção dialógica do conhecimento** entre profissionais e usuários, sendo importante para **viabilizar a promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos**.
(LOURENÇO et al., 2022)

A partir das ações de educação em saúde objetiva-se a construção de **processos sociais emancipatórios** e a **autonomia** dos indivíduos, auxiliando a **compreensão** do usuário quanto a sua **doença**, assim como a capacidade de tomar **decisões** em relação a ela.
(LOURENÇO et al., 2022)

A prática da educação em saúde deve **romper** com a **hierarquização** entre os saberes ao partir do **diálogo horizontal** entre usuários do serviço e profissionais de saúde, priorizando a **participação ativa** dos usuários (PEREIRA et al., 2021)

Em quais momentos a educação em saúde pode ser realizada no cotidiano dos serviços de saúde da APS?

Grupos

Salas de espera

Visita domiciliar

Consultas

Ações no território/campanhas

Como a educação em saúde pode contribuir com a melhoria nos processos de atenção à saúde na APS, em especial da saúde da pessoa idosa e das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis?

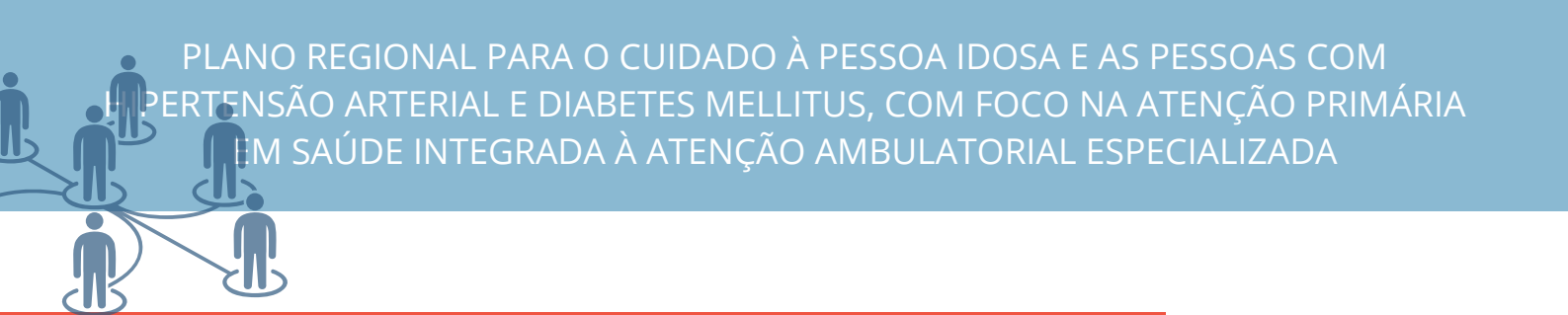
Facilita a compreensão e adaptação do indivíduo quanto ao processo saúde/doença;

Contribui para a promoção do autocuidado e redução do risco de complicações;

Favorece uma melhor adesão ao tratamento, fortalecendo a autonomia e qualidade de vida;

Estimula transformações quanto a hábitos de vida mais saudáveis e enfrentamento de vulnerabilidades;

Fortalece a corresponsabilização pessoal e social do indivíduo quanto a sua saúde, contribuindo para a tomada de decisões.



ESTE PLANO REGIONAL FOI INTEIRAMENTE BASEADO NAS SEGUINTE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERNARDO, R. L. et al. Ações de educação em saúde: abordagem de pacientes adultos diagnosticados com diabetes mellitus e/ou hipertensão arterial na unidade básica de saúde da família Gothardo Firmino Neto - Volta Grande III. Tudo é Ciência: Congresso Brasileiro de Ciências e Saberes Multidisciplinares, [S. l.], n. 1, p. 1-8, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica n. 36. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 36)

BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 37)

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias. Ministério da Saúde, 2013. p.28

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Orientações técnicas para a implementação de Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa no Sistema Único de Saúde – SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. p.91

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.604, de 18 de outubro de 2023. Institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES), no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023.

FERREIRA, L. et al.. Educação Permanente em Saúde na atenção primária: uma revisão integrativa da literatura. Saúde em Debate, v. 43, n. 120, p. 223-239, jan. 2019.

KASPER, M. et al. Reunião de equipe de saúde na atenção básica: contribuições da análise institucional. Caderno Pedagógico, [S. l.], v. 21, n. 2, p. e2900, 2024.

MENDES, E.V. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da consolidação da estratégia da saúde da família. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012. 512 p.

MENDES, E.V. Desafios do SUS. 1º edição - Brasília, DF: CONASS, 2019. 869 p.

MORAIS, A. B. M. de et al. Permanent health education: Potentials, challenges and trends for the work process. Seven Editora, [S. l.], p. 599-607, 2024.

MORAES, E. N., LOPES, P. R. R. Manual de avaliação multidimensional da pessoa idosa para a atenção primária à saúde: aplicações do IVCF-20 e do ICOPE – Linha de cuidado: saúde da pessoa idosa. – Brasília, DF: Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2023. 110 p.

NASCIMENTO, A. K. da C.; BADUY, R. S. Simulação, oficina e roda de conversa: estratégias de aprendizagem ativa na saúde. Revista Educação em Debate, Fortaleza, ano 43, n. 84, p. 152-167, jan./abr. 2021.

PEREIRA, A. J. A. et al. Health education in the prevention of hypertension disorders: an experience report. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 3, p. e7710312341, 2021.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Plano Estadual de Saúde: 2020-2023/ Organização Grupo de Trabalho Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Gestão - Porto Alegre: Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, 2021. 308 p.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual de Saúde. Atenção à pessoa idosa na Atenção Primária em Saúde. Nota técnica nº 02/2022 - Política de Saúde da Pessoa Idosa/DPCV/DAPPS/SES. Porto Alegre, Jul., 2022.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual de Saúde. NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 06/2023. ATENÇÃO AO INDIVÍDUO COM DIABETES TIPO II NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, julho de 2023.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual de Saúde. NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 06/2023. ATENÇÃO AO INDIVÍDUO COM DIABETES TIPO II NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, julho de 2023.

RIO GRANDE DO SUL. SECRETARIA DA SAÚDE. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E POLÍTICAS DE SAÚDE. MANUAL DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL (IVCF-20): ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL: ESP/SES, 2023. 36P.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual de Saúde. NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 05/2023. ATENÇÃO AO INDIVÍDUO COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, julho de 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. UNA-SUS/UFMA. Redes de Atenção à Saúde: Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no Âmbito do Sistema Único de Saúde/Ana Emilia Figueiredo de Oliveira; Francisca Luzia Soares Macieira de Araújo; Judith Rafaelle Oliveira Pinho; Marcos Antônio Barbosa Pacheco (Org.). - São Luís: EDUFMA, 2017.

SOCIEDADE BENEFICIENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN (SBIBAE). NOTA TÉCNICA PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA - SAÚDE DA PESSOA IDOSA. São Paulo: Hospital Israelita Albert Einstein: Ministério da Saúde, 2018. 56 p.

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO RS. Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde. Reunião de Equipe na Atenção Primária à Saúde Divisão de Atenção Primária à Saúde - 1º edição. Porto Alegre: Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, 2022.